

方剂梳理

方剂卡片合集 PDF 可搜索版

当前导出

45 首

导出方式

复用 Web 预览样式，文字可复制检索

资料定位

中医方剂学习资料

本次包含

麻黄汤、越婢加术汤、厚朴麻黄汤、越婢汤、麻黄加术汤、小青龙加石膏汤、葛根加半夏汤、麻杏苡甘汤、麻黄连翘赤小豆汤、大青龙汤、柴胡桂枝汤、麻杏石甘汤、甘草附子汤、麦门冬汤、茯苓饮、葛根芩连汤、橘枳姜汤、大陷胸汤、大黄附子汤、柴胡加芒硝汤、四逆散、桂枝附子汤、麻黄附子细辛汤、白虎加桂枝汤 等共 45 首

学习资料，仅供中医学习交流，不作为诊疗处方依据。具体用药请咨询专业医师。

如何使用本资料

先辨方证，再看方名；先抓主症，再看兼症

1. 先看目录

目录按当前数据库顺序列出方剂、病理归类和辨证要点。点击目录中的方剂名，可跳转到对应卡片。

2. 抓辨证要点

每张卡片优先看病理标签、方剂名病理、辨证要点和临床症状，不要只按现代病名套方。

3. 对照类方

遇到相似主症时，重点看“对比”部分，分清表里寒热、虚实、水血气等边界。

4. 医案用于校验

医案后的十二字病理分析用于复盘症状如何落到病理标签，不作为直接处方依据。

建议学习顺序：目录定位 → 方剂卡片 → 相关条文 → 胡希恕/李冠杰要点 → 类方对比 → 医案复盘。

本资料用于学习、复习和辨方训练；临床用药必须结合面诊、舌脉、剂量、禁忌和专业医师判断。

表证目录 (1/2)

序号	方剂	归类	辨证要点
01	麻黄汤	表实	恶寒无汗是第一抓手。；头痛发热、身疼腰痛、骨节疼痛，身痛较桂枝汤证明显。
02	越婢汤	表实 / 里热	第一抓手：一身悉肿 + 续自汗出 + 口渴 + 脉浮，风水夹热四大主症。；水肿特点：眼睑头面先肿，迅速蔓延全身，皮肤绷急光亮，属阳水实证。
03	麻杏石甘汤	表实 / 里热	汗出而喘、身无大热是条文主。；汗出多由里热蒸汗，汗黏稠、味重。
04	桂枝附子汤	表虚 / 里寒 / 水实 / 阴证	风湿相搏：身体疼烦，不能自转侧是核心。；脉浮虚而涩：表在而虚，血行不流利。
05	桂枝加桂汤	表虚 / 气实	桂枝汤证而气上冲剧烈是本方总纲。；气从少腹上冲心胸咽喉是最核心抓手，常呈发作性。
06	桂枝加厚朴杏子汤	表虚 / 里寒 / 气实	第一抓手：桂枝汤证 + 咳喘/微喘，表虚仍为主。；喘家：素有喘疾，外感诱发或加重，非临时咳喘。
07	葛根汤	表实 / 里热	项背强几几,无汗恶风者；项背强几几：颈背拘急、俯仰不便，葛根专证（落枕、颈椎病等须见方证）。
08	桂枝甘草汤	表虚 / 气实	表虚、心下悸，气上冲、欲得按而无里实者。；叉手自冒心是强佐证，活动后更易诱发。

表证目录 (2/2)

序号	方剂	归类	辨证要点
09	桂枝汤	表虚	汗出恶风是第一抓手，不是见发热就用。；头痛、发热、鼻鸣、干呕，可构成太阳中风证。
10	桂枝加葛根汤	表虚 / 里热	汗出恶风+项背强几几是核心抓手。；基础必须有桂枝汤证：汗出、恶风、发热头痛、脉浮缓或浮弱。
11	桂枝加附子汤	表虚 / 水虚 / 阴证	汗漏不止+恶风是第一抓手。；本方是桂枝汤证陷入阴证/少阴表虚，不是普通桂枝汤证。

里证目录 (1/3)

序号	方剂	归类	辨证要点
12	葛根加半夏汤	表实 / 水实 / 里虚	葛根汤证而呕者是条文核心。；抓手一：无汗恶寒、项背强、脉浮紧，葛根汤证底子。
13	柴胡桂枝汤	表虚 / 里虚 / 半热	桂枝汤证 + 柴胡证并存，太阳少阳合病。；有少阳证存在时不可单纯发汗，须表里和解同施。
14	大陷胸汤	里实 / 里热 / 半热 / 水实	主抓手：心下至少腹硬满而痛不可近，或心下痛按之石硬。；必须同时找里热/里实证据：舌燥而渴、便秘、潮热、烦躁、苔黄燥、脉沉紧有力。
15	大黄附子汤	里实 / 里寒 / 水实 / 血实 / 阴证	胁下偏痛、脉紧弦是条文核心，不可只看便秘。；病机是寒实于里，以温药下之，不是阳明燥热承气证。
16	柴胡加芒硝汤	里实 / 里热 / 半热	第一抓手：胸胁满而呕 + 日晡所发潮热，少阳证与阳明里热实同时存在。；第二抓手：大便硬、大便难，或微利但仍有潮热腹满；微利多按热利或误下后余实理解。
17	四逆散	里实 / 半热 / 血虚 / 气实	第一抓手是柴胡证加心下或腹部实满痛，不是见四肢冷就用。；大柴胡汤证不可下者是重要边界：有胸胁苦满、心下抵抗，但大便不硬或反偏溏。
18	白虎加桂枝汤	表虚 / 里热	桂枝甘草汤证又见白虎汤证，太阳阳明合病、表里并病。；无往来寒热、胸胁苦满等柴胡证时，方为本方机会。
19	黄芪桂枝五物汤	表虚 / 里虚 / 血虚	摸皮肤像隔着一层东西，像不是自己的；血痹不是单纯瘀血攻逐证，而是表虚、里虚、血脉失养兼痹阻。

里证目录 (2/3)

序号	方剂	归类	辨证要点
20	苓桂术甘汤	表虚 / 里寒 / 里虚 / 水实 / 气实	心下逆满 + 气上冲胸 + 起则头眩是本方核心组合。；脉沉紧提示里有水饮；苔白滑、齿痕、胃中振水声可作佐证。
21	苓桂枣甘汤	表虚 / 里虚 / 水实 / 气实	脐下悸是本方最核心、最有特异性的抓手。；欲作奔豚不是已经严重奔豚，而是少腹气水将要上冲的状态。
22	桂枝加黄芪汤	表虚 / 里虚 / 水实	黄汗病：出汗、发热、身肿痛；黄芪在本方是补表气、助桂枝汤解表虚水湿，不是见气虚就加。
23	桂枝人参汤	表虚 / 里寒 / 里虚	第一个抓手：下利不止，且偏虚寒，清稀不臭、腹冷、喜温。；第二个抓手：心下痞硬，是胃虚中寒后心下部痞塞拘硬，不是硬痛拒按。
24	竹叶汤	表虚 / 阴证 / 里热 / 里虚 / 血虚	产后或大虚背景是本方成立的前提。；发热、面正赤、喘而头痛是原文抓手。
25	桂枝新加汤	表虚 / 里虚 / 水虚	桂枝汤证 + 津液虚 + 胃气虚 + 身疼痛。；身痛不是表实闭郁，而是津血不足、筋肉失养，所以不能再用麻黄类强发汗。
26	厚朴生姜半夏甘草人参汤	里虚 / 气实	腹胀满，虚胀为特征；腹胀按之不坚，不甚痛，时轻时重
27	小青龙汤	表实 / 里虚 / 里寒 / 水实	伤寒表不解，心下有水气是方证核心。；咳喘、痰涎清稀量多、鼻流清涕，舌苔白滑。

里证目录 (3/3)

序号	方剂	归类	辨证要点
28	茯苓甘草汤	表虚 / 里虚 / 水实	心下悸、胃脘跳动是本方最重要抓手。；第73条与五苓散鉴别：五苓散汗出而渴，本方不渴或渴不明显。

半证目录

序号	方剂	归类	辨证要点
29	葛根芩连汤	表虚 / 里热 / 半热	下利偏热：臭秽、黏滞、肛门灼热、口苦口干、苔黄腻。；兼汗出、喘、胸中烦热，或项背拘急、头身困重。
30	柴胡加龙骨牡蛎汤	半热 / 半虚 / 里虚 / 里实 / 水实 / 气实	柴胡证 + 烦惊心悸 + 小便不利是第一抓手。；胸满烦惊：胸胁满闷、心烦、惊恐、坐卧不安，精神症状突出。
31	桔梗汤	半热	咽痛，扁桃体红肿为典型。；咽痛忌发汗，有表证亦慎麻桂，可葛根汤加桔梗。

水证目录 (1/2)

序号	方剂	归类	辨证要点
32	越婢加朮汤	表实 / 里热 / 水实	越婢汤证见小便不利或湿痹疼痛，是本方基本入口。；一身面目黄肿 + 小便不利 + 脉沉/浮滑。
33	厚朴麻黄汤	表实 / 里热 / 水实 / 气实	咳而脉浮、胸满喘满。；可兼里热：烦躁、口渴、黄痰、脉洪大，石膏为主药。
34	麻黄加朮汤	表实 / 水实	第一抓手：身体烦疼 + 恶寒无汗 + 身重酸困；疼痛特点是「烦疼」：疼得厉害、酸重难受、转侧不利，不是单纯的麻黄汤身痛。
35	小青龙加石膏汤	表实 / 里寒 / 里热 / 水实 / 半虚 / 气实	小青龙汤证 + 烦躁 = 小青龙加石膏汤证，是核心公式。；抓手一：咳喘、痰多清稀或黄白相兼，心下有水气。
36	麻杏苡甘汤	表实 / 里热 / 水实	一身尽疼，发热，日晡所剧是条文核心。；主治湿热痹痛：周身关节痛、身重或肿、筋急拘挛。
37	麻黄连翘赤小豆汤	表实 / 里热 / 水实	伤寒瘀热在里，身必黄是条文主轴。；抓手一：发热恶寒、无汗、脉浮，表邪未解。
38	大青龙汤	表实 / 里热 / 水实	脉浮紧、发热恶寒、身疼痛、不汗出而烦躁是核心方证。；脉浮缓、身不疼但重、乍有轻时、无少阴证，主体表停饮。
39	甘草附子汤	表虚 / 水实 / 阴证	骨节疼烦，掣痛不得屈伸，近之则痛剧是核心。；汗出短气、小便不利、恶风不欲去衣，提示虚寒湿痹。

水证目录 (2/2)

序号	方剂	归类	辨证要点
40	麦门冬汤	里热 / 水虚 / 气实	咳逆、咽干口燥、咽喉不利者；咳逆上气，咳嗽较深
41	茯苓饮	里虚 / 水实 / 气实	胸满、腹胀、心下痞，兼食欲不振；胃中停饮：吐水、痰水、胃内振水音或苔厚腻
42	麻黄附子细辛汤	表实 / 里寒 / 水实 / 阴证	第一抓手：少阴始得、反发热、脉沉。；反字贯发热与脉沉：少阴本不发热、脉不当沉，皆属「反」。
43	射干麻黄汤	表实 / 里寒 / 里虚 / 水实 / 气实	喉中水鸡声是第一抓手：喉间痰鸣、湿鸣，呼吸或说话时痰声明显。；咽喉不利、痰结咽中明显，是本方区别小青龙汤的重要点。
44	五苓散	表虚 / 水实 / 气实	小便不利 + 渴欲饮水（消渴、越喝越渴）是第一抓手。；水入则吐为水逆，为本方典型证。

气证目录

序号	方剂	归类	辨证要点
45	橘枳姜汤	气实	胸中气塞为主，胸满、心下憋、堵闷明显；短气可见，但短气不是主症；短气急迫为主者偏茯苓杏仁甘草汤，



麻黄汤

组成

麻黄三两去节 桂枝二两去皮 甘草一两炙 杏仁七十枚去皮尖

比例

麻黄3 桂枝2 杏仁3 炙甘草1

病理

表实

病理症状

表实

恶寒、无汗、脉浮紧、身疼腰痛、骨节疼痛。

易混淆方

葛根汤

大青龙汤

麻杏石甘汤

小青龙汤

麻黄附子细辛汤

方剂	核心区别
麻黄汤	太阳表实，恶寒无汗、身疼腰痛、骨节疼痛、脉浮紧、无汗而喘。
葛根汤	表实兼项背强，项背强几几、无汗恶风，项背拘急更突出。
大青龙汤	表实里热，无汗身疼、烦躁、口渴或里热明显，比麻黄汤多烦躁里热。
麻杏石甘汤	肺热喘，汗出而喘、身无大热、里热壅肺，不是无汗表闭。
小青龙汤	表寒里饮，恶寒无汗、咳嗽痰稀、心下水气，饮证更突出。
麻黄附子细辛汤	少阴表实，恶寒无汗、脉沉、但欲寐、精神沉衰，不是太阳脉浮紧。

辨证要点

恶寒无汗是第一抓手。

头痛发热、身疼腰痛、骨节疼痛，身痛较桂枝汤证明显。

脉浮紧、有力提示表实寒闭，非表虚汗出。

相关原文

《伤寒论》35：太阳病，头痛，发热，身疼，腰痛，骨节疼痛，恶风，无汗而喘者，麻黄汤主之。

《伤寒论》36：太阳与阳明合病，喘而胸满者，不可下，宜麻黄汤。

《伤寒论》37：太阳病，十日以去，脉浮细而嗜卧者，外已解也；设胸满胁痛者，与小柴胡汤；脉但浮者，与麻黄汤。

《伤寒论》46：太阳病，脉浮紧，无汗，发热，身疼痛，八九日不解，表证仍在，此当发其汗。服药已微除，其人发烦目瞑，剧者必衄，衄乃解。所以然者，阳气重故也。麻黄汤主之。

《伤寒论》51：脉浮者，病在表，可发汗，宜麻黄汤。

《伤寒论》52：脉浮而数者，可发汗，宜麻黄汤。

《伤寒论》55：伤寒脉浮紧，不发汗，因致衄者，麻黄汤主之。

《伤寒论》235：阳明病，脉浮，无汗而喘者，发汗则愈，宜麻黄汤。

医案

（胡希恕验案，篮球后冷水浴感冒）：陈某，男，24岁。昨日打篮球后用凉水洗澡，今早恶寒、身热38.6℃、无汗、头痛、身酸痛，口不渴，苔薄白，脉浮紧。胡老辨为太阳表实证，予麻黄汤：麻黄10g、桂枝6g、炙甘草6g、杏仁10g。急煎服后盖被，得微汗出，热渐退，未再服药，调养二日自愈。

十二字病理分析：

表实：冷水外束、恶寒无汗、脉浮紧、身酸痛，寒邪闭表。



越婢汤

组成

麻黄六两 石膏半斤 生姜三两 大枣十五枚 甘草二两炙

比例

麻黄6 生石膏8 炙甘草2 生姜3 大枣6

病理

表实

里热

病理症状

表实

风水在表、一身悉肿、脉浮恶风。

里热

水气郁而化热、续自汗出、口渴。

易混淆方

越婢汤

防己黄芪汤

五苓散

真武汤

麻杏石甘汤

方剂	核心区别
越婢汤	风水夹热实证， 一身悉肿、汗出、口渴、脉浮 ，表实+里热+水实。
防己黄芪汤	表虚湿盛证， 身重、汗出恶风、乏力、不渴 ，虚证，无里热。
五苓散	水停下焦证， 小便不利、口渴水逆、少腹满 ，偏里水，表证不明显。
真武汤	阳虚水泛证， 全身肿、畏寒肢冷、腰以下肿甚、脉沉 ，阴水，属里虚寒。
麻杏石甘汤	肺热咳喘证， 汗出而喘、身热不解、口渴 ，以咳喘为核心，无明显水肿。

辨证要点

第一抓手：一身悉肿 + 续自汗出 + 口渴 + 脉浮，风水夹热四大主症。

水肿特点：眼睑头面先肿，迅速蔓延全身，皮肤绷急光亮，属阳水实证。

汗出特点：虽然自汗出，但水肿不消，汗为内热迫津所致，非表虚汗。

渴与不渴：口渴是里热确证，原文「脉浮不渴」疑为「脉浮而渴」，临床多见口渴。

禁忌：阴水（脾肾阳虚、畏寒肢冷、腰以下肿甚）禁用；阴虚津亏者慎用。

相关原文

《金匮要略·水气病脉证并治第十四》第23条：风水恶风，**一身悉肿**，脉浮不渴，**续自汗出**，无大热，越婢汤主之。

《金匮要略·水气病脉证并治第十四》：风水，其脉自浮，**外证骨节疼痛，恶风**。

《金匮要略·水气病脉证并治第十四》：**脉浮而洪，浮则为风，洪则为气。风气相搏，风强则为隐疹，身体为痒**，痒为泄风，久为痼癰。气强则为水，难以俯仰。风气相击，身体洪肿，汗出乃愈。

《金匮要略·水气病脉证并治第十四》：**里水者，一身面目黄肿，其脉沉，小便不利**，故令病水。假如小便自利，此亡津液，故令渴也。越婢加术汤主之。

《金匮要略·水气病脉证并治第十四》：**咳而上气，此为肺胀，其人喘，目如脱状**，脉浮大者，越婢加半夏汤主之。

医案

医案1（胡希恕，慢性肾炎水肿案）：佟某，男，63岁，1965年7月初诊。慢性肾炎住院3个月，尿蛋白(+)~(+++)，近症：**四肢及颜面皆肿，皮肤灰黑，腹大脐平，纳差，小便量少，汗出不恶寒**，舌苔白腻，脉沉细。辨水饮内停、外邪郁表、郁久化热，予越婢汤：麻黄12g，生姜10g，大枣4枚，炙甘草6g，生石膏45g。服2剂小便增多，纳差好转；继服20余剂，浮肿腹水消，尿蛋白(-)，病愈出院。

十二字病理分析：

表实：**颜面四肢肿、汗出、恶风不显**，风水在表。

里热：**汗出、郁久化热**，水郁化热。

水实：**一身悉肿、小便量少、腹大脐平**，水湿泛滥。



麻杏石甘汤

组成

麻黄四两去节 杏仁五十枚去皮尖 甘草二两炙 石膏半斤碎绵裹

比例

麻黄4 杏仁2 石膏8 炙甘草2

病理

表实

里热

病理症状

表实

外邪未解，仍须麻黄宣肺解表；虽有汗出，仍属表实证，非桂枝汤之表虚。

里热

舌红苔黄、脉数滑或近洪大、烦躁、口干、痰黄、鼻煽。

易混淆方

桂枝加厚朴杏子汤

小青龙加石膏汤

大青龙汤

白虎汤

方剂	核心区别
麻杏石甘汤	肺热喘，汗出而喘、无大热、口渴或苔黄。
桂枝加厚朴杏子汤	表虚喘，汗出恶风、无里热、痰白。
小青龙加石膏汤	寒饮兼热，心下水、咳喘痰稀兼烦渴。
大青龙汤	表实里热，无汗身痛、不汗出而烦躁。
白虎汤	阳明里热，大热大汗大渴脉洪大，喘不是主症。

辨证要点

汗出而喘、身无大热是条文主。

汗出多由里热蒸汗，汗黏稠、味重。

严格说仍属表实证，但表实程度不及大青龙汤；无体表停饮。

不宜连续重服麻黄；一服见效后减麻黄或转方，防过汗伤正。

相关原文

《伤寒论》63：发汗后，不可更行桂枝汤。汗出而喘，无大热者，可与麻黄杏仁甘草石膏汤。

《伤寒论》162：下后，不可更行桂枝汤。若汗出而喘，无大热者，可与麻黄杏仁甘草石膏汤。

医案

（胡希恕，1965）：陈某，男，24岁。恶寒身疼、咳喘咽干，自服退热药后汗出不恶寒，仍身疼咳喘、吐白痰、口干思饮，苔白舌尖红，脉滑数。证属外寒里热、肺气不宣，予麻杏石甘汤加半夏。服2剂汗喘减，继桑杏汤加减6剂诸症已。

十二字病理分析：

表实：身疼、咳喘未解，外邪未罢。

里热：口干思饮、舌尖红、脉滑数，里热壅肺。

气逆：咳喘、吐痰，肺气上逆。



桂枝附子汤

组成

桂枝四两去皮 附子三枚炮去皮破八片 甘草二两炙 生姜三两切 大枣十二枚擘

比例

桂枝4 炮附子3 生姜3 大枣5 炙甘草2

病理

表虚

里寒

水实

阴证

病理症状

表虚

脉浮虚而涩、恶风寒，风湿在表。

里寒

不渴、里无热，寒湿痹阻经络。

水实

病人素多湿，风湿相搏；湿胜则身重疼痛，可兼停饮致气短心悸。

阴证

机能沉衰，脉浮而按之无力；附子三枚用量大，示里虚寒偏重。

易混淆方

甘草附子汤

桂枝芍药知母汤

桂枝加附子汤

桂枝汤

麻黄加术汤

方剂	核心区别
桂枝附子汤	风湿表虚，身体疼痛、不能自转侧、脉浮虚涩、恶风汗出。
甘草附子汤	关节痛更剧，掣痛不得屈伸、短气、小便不利。
桂枝芍药知母汤	历节水肿夹热，脚肿如脱、头眩短气、欲吐。
桂枝加附子汤	桂枝汤证兼阳虚漏汗，汗漏不止、恶风、小便难、四肢微急，以固表扶阳为主。
桂枝汤	普通表虚，汗出恶风、头痛发热，无湿痹重痛。
麻黄加术汤	表实湿痹，无汗、身体疼、湿重。

辨证要点

风湿相搏：身体疼痛，不能自转侧是核心。

脉浮虚而涩：表在而虚，血行不流利。

不呕不渴：不呕无里饮，不渴无里热。

与甘草附子汤：后者骨节掣痛、近之痛剧、汗出短气、小便不利、身微肿更重。

与桂枝加附子汤：后者漏汗、小便难、四肢微急，附子仅一枚。

相关原文

《伤寒论》174：伤寒八九日，风湿相搏，身体疼痛，不能自转侧，不呕、不渴，脉浮虚而涩者，桂枝附子汤主之。

《伤寒论》174：若其人大便硬，小便不利者（《宋本》作小便自利），去桂加白术汤主之。

《金匱要略·痉湿喝病》：伤寒八九日，风湿相搏，身体疼痛，不能自转侧，不呕不渴，脉浮虚而涩者，桂枝附子汤主之；若大便坚，小便自利者，去桂加白术汤主之。

去桂加白术汤服法：初一服其身如痹，半日许复服；三服都尽，其人如冒状，勿怪，此以附子术并走皮内逐水气。

医案

（胡希恕讲稿，自用）：胡老抽陀螺用力过大，后脊梁肌肉疼，服桂枝附子汤后明显缓解。属一般性肢体肌肉疼痛，方证不必拘泥关节风湿条文。



桂枝加桂汤

组成

桂枝五两去皮 芍药三两 生姜三两切 甘草二两炙 大枣十二枚擘

比例

桂枝5 芍药3 生姜3 炙甘草2 大枣5

病理

表虚

气实

病理症状

表虚

有**太阳中风**、**汗出恶风**、**脉浮缓**或**表未解**等桂枝汤证背景。

气实

气从少腹上冲心胸咽喉，气上冲较桂枝汤证更剧烈。

易混淆方

桂枝汤

苓桂枣甘汤

奔豚汤

桂枝去芍药汤

桂枝甘草汤

桂枝甘草龙骨牡蛎汤

方剂	核心区别
桂枝加桂汤	桂枝汤证兼气冲剧烈， 气从少腹上冲心 、 欲作奔豚 ，无明显水饮主轴。
桂枝汤	太阳中风表虚， 汗出恶风 、 发热 、 脉浮缓 ，气上冲不剧烈。
苓桂枣甘汤	少腹水气上冲， 脐下悸 、 欲作奔豚 、 小便不利 ，水饮为主。
奔豚汤	奔豚已作， 气上冲胸 、 腹痛 、 往来寒热 ，热象与半表半里更明显。
桂枝去芍药汤	胸阳不展气上冲， 脉促胸满 ，胸满为主，不以少腹上冲心为主。
桂枝甘草汤	心阳虚急， 叉手自冒心 、 心下悸 、 欲得按 ，无少腹上冲。
桂枝甘草龙骨牡蛎汤	火逆烦躁， 烦躁 、 心悸 、 惊恐不安 ，重在安神潜镇。

辨证要点

桂枝汤证而气上冲剧烈是本方总纲。

气从少腹上冲心胸咽喉是最核心抓手，常呈发作性。

本方治的是**表虚气冲**，不是胃肠暖气、反酸、痰饮上逆的通用方。

偏热、口燥咽干、舌红苔黄者慎用，桂枝加量偏温，误用可烦躁不适。

相关原文

《伤寒论》第117条：烧针令其汗，针处被寒，核起而赤者，必发奔豚，**气从小腹上冲心者**，灸其核上各一壮，与桂枝加桂汤。更加桂二两也，本云桂枝汤，今加桂五两，所以加桂者，**以能泄奔豚气也**。

《金匱要略·奔豚气病》：发汗后，烧针令其汗，针处被寒，核起而赤者，必发奔豚，**气从少腹上至心**，灸其核上各一壮，与桂枝加桂汤主之。

医案

（曹颖甫《经方实验录》，奔豚其二）：周某，住浦东。初诊见**气从少腹上冲心**，一日四五度发，发则白津出。辨作奔豚，用桂枝加桂汤意：肉桂心、川桂枝、白芍、炙甘草、生姜、大枣。后症状缓解，发作减少。

十二字病理分析：

表虚：本方以桂枝汤为底，虽案中未详汗恶风，仍取营卫不和、表虚气冲之法。

气实：**气从少腹上冲心，一日四五度发**，为气逆上冲核心证。

里虚：发则白津出，兼胃气不和、津液上泛。



桂枝加厚朴杏子汤

组成

桂枝三两去皮 甘草二两炙 生姜三两切 芍药三两 大枣十二枚擘 厚朴二两炙去皮 杏仁五十枚去皮尖

比例

桂枝3 炙甘草2 生姜3 芍药3 大枣5 厚朴2 杏仁3

病理

表虚

里寒

气实

病理症状

表虚

桂枝汤证：发热、恶风寒、汗出、脉浮缓弱。

里寒

痰清稀白、舌淡苔白、无里热。

气实

咳逆喘满、短气、喉中痰鸣。

易混淆方

桂枝汤

麻杏石甘汤

小青龙汤

大青龙汤

厚朴生姜半夏甘草人参汤

方剂	核心区别
桂枝加厚朴杏子汤	桂枝汤证兼喘，汗出恶风、喘、无里热。
桂枝汤	表虚汗出恶风，无喘满。
麻杏石甘汤	肺热喘，汗出而喘、舌红苔黄、脉滑数。
小青龙汤	表寒里饮喘咳，痰稀白沫、不渴、寒饮。
大青龙汤	表实里热，无汗身痛、烦躁。
厚朴生姜半夏甘草人参汤	虚胀气逆，腹胀满、按之不坚，非表证喘。

辨证要点

第一抓手：桂枝汤证 + 咳喘/微喘，表虚仍为主。

喘家：素有喘疾，外感诱发或加重，非临时咳喘。

必须无里热：无舌红苔黄、烦躁、脉洪滑数、汗黏稠臭。

痰偏清稀白，非黄稠热痰。

相关原文

《伤寒论》18：喘家，作桂枝汤，加厚朴、杏子佳。

《伤寒论》43：太阳病，下之微喘者，表未解故也，桂枝加厚朴杏子汤主之。

医案

(冯世纶师承医案，支气管炎)：段某，男，5岁。自幼冬春易感冒，咳嗽难愈；本次感冒后咳嗽、鼻流清涕、时喘、吐白痰，服抗菌药效果不佳，且曾呕吐。刻诊仍咳、时喘、汗出恶风，苔白，脉弱，西医诊断为支气管炎。辨为太阳表虚夹饮，予桂枝加厚朴杏子汤：桂枝、白芍、杏仁、厚朴、生姜各10g，炙甘草6g，大枣4枚。每剂服一天半，3剂后咳喘减轻，继服6剂，诸症消失。

十二字病理分析：

表虚：汗出恶风、脉弱，桂枝汤证底子明确。

气实：咳嗽、时喘，肺气上逆，厚朴杏仁降气平喘。

水实：鼻流清涕、吐白痰、苔白，寒饮在表肺之间。

里寒：白痰清涕、无口渴苔黄等里热表现，方取温宣。



葛根汤

组成

葛根四两 麻黄三两去节 桂枝二两去皮 生姜三两切 甘草二两炙 芍药二两 大枣十二枚擘

比例

葛根4 麻黄3 桂枝2 生白芍2 炙甘草2 生姜3 大枣5

病理

表实

里热

病理症状

表实

无汗、恶寒恶风、脉浮紧或浮数。

里热

热性下利，项背强有湿热的原因

易混淆方

桂枝加葛根汤

麻黄汤

大青龙汤

柴胡桂枝汤

方剂	核心区别
葛根汤	太阳表实项背强， 项背强几几、无汗恶风、脉浮紧 。
桂枝加葛根汤	太阳表虚项背强， 汗出恶风、脉浮缓 ，无麻黄。
麻黄汤	表实无汗身痛， 恶寒身疼痛 ，项背强不突出。
大青龙汤	表实兼里热， 不汗出而烦躁 。
柴胡桂枝汤	太阳少阳合病， 微恶寒、支节烦疼、心下支结、微呕 。

辨证要点

项背强几几,无汗恶风者

项背强几几：颈背拘急、俯仰不便，葛根专证（落枕、颈椎病等须见方证）。

无汗恶风：无汗为表实关键；有汗则用桂枝加葛根汤。

恶寒特别厉害：临床比「恶风」更确切，感冒流感初起常用。

项背强可不极显著；**无汗+恶寒重**即可考虑，不必悉具。

太阳阳明合病：**表证兼自下利**，多属热性下利，仍宜葛根汤发汗。

兼呕：胃虚停饮，用**葛根加半夏汤**；口舌干燥加石膏。

咽痛有表证：葛根汤加桔梗；

相关原文

《伤寒论》31：太阳病，**项背强几几、无汗恶风，葛根汤主之**。

《伤寒论》14：太阳病，项背强几几，**反汗出恶风者，桂枝加葛根汤主之**（有汗表虚鉴别）。

《伤寒论》32：太阳与阳明合病，**必自下利者，葛根汤主之**（表证兼热性下利）。

《伤寒论》33：太阳与阳明合病，**不下利但呕者，葛根加半夏汤主之**。

《金匱要略·痉湿喝》：太阳病，无汗而小便反少，气上冲胸，口噤不得语，**欲作刚痉，葛根汤主之**。

医案

（胡希恕，张某感冒）：男，44岁。**恶寒、无汗、项背强、头痛、腿痛、口唇干**，苔薄白，脉浮紧。辨太阳阳明合病，予**葛根汤加石膏**，**一剂感冒证解**。

十二字病理分析：

表实：**恶寒无汗、脉浮紧**，项背强，表实闭郁。

里热：**口唇干**，轻热伤津，加石膏。



桂枝甘草汤

组成

桂枝四两去皮 甘草二两炙

比例

桂枝4 炙甘草2

病理

表虚

气实

病理症状

表虚

汗出、畏风。

气实

气上冲于心胸，心下悸、叉手自冒心、欲得按。

易混淆方

桂枝甘草龙骨牡蛎汤

苓桂术甘汤

炙甘草汤

茯苓甘草汤

方剂	核心区别
桂枝甘草汤	心阳不足气上冲，发汗过多、叉手自冒心、心下悸欲得按。
桂枝甘草龙骨牡蛎汤	加惊烦，烦躁惊悸、失眠。
苓桂术甘汤	水饮上冲，心下逆满、起则头眩、脉沉紧。
炙甘草汤	阴血阳气俱虚，脉结代、心动悸。
茯苓甘草汤	胃中停水，心下悸、四肢厥、口不渴。

辨证要点

表虚、心下悸，气上冲、欲得按而无里实者。

叉手自冒心是强佐证，活动后更易诱发。

心悸多为阵发、一过性，心胸部气冲感集中。

本方治疗心悸确实有效，但注意要大量用

急性病可见于高热汗后，感冒后

慢性病可见于冠心病，心律失常

相关原文

《伤寒论》64：发汗过多，其人叉手自冒心，心下悸，欲得按者，桂枝甘草汤主之。

医案

(门纯德医案)：男，46岁，雨中外感后自服大剂葱姜红糖汤，得大汗后风寒虽解，却失眠3个月。诊见面色青，双目布满血丝，彻夜不卧、烦躁徘徊，白天蜷卧少言少食，脉弦细，舌淡苔少。安神药少效。予桂枝甘草汤，睡前服，次晨酣睡。

十二字病理分析：

表虚：过汗后病起，表阳受损。

津虚：大汗伤津，舌淡苔少。

气实：烦躁不卧、心神不安，为气冲心胸、心阳不宁。



桂枝汤

组成

桂枝三两去皮 芍药三两 甘草二两炙 生姜三两切 大枣十二枚擘

比例

桂枝3 生白芍3 生姜3 大枣5 炙甘草2

病理

表虚

病理症状

表虚

营卫不和，腠理不固，汗出恶风、发热头痛。

易混淆方

麻黄汤

葛根汤

桂枝加葛根汤

小建中汤

方剂	核心区别
桂枝汤	太阳表虚，汗出恶风、脉浮缓、鼻鸣干呕。
麻黄汤	太阳表实，无汗恶寒、身疼、脉浮紧、喘。
葛根汤	表实项背强，项背强几几、无汗。
桂枝加葛根汤	表虚项背强，汗出恶风+项背强。
小建中汤	里虚腹急痛，腹中急痛、喜温按、虚劳悸衄。

辨证要点

汗出恶风是第一抓手，不是见发热就用。

头痛、发热、鼻鸣、干呕，可构成太阳中风证。

脉多浮缓、浮弱、浮虚；人常偏虚，汗孔关不住。

可治定时发热自汗，关键是“先其时”服药取微汗。

表实无汗、脉浮紧、身痛重者禁用原方，应与麻黄汤、葛根汤类鉴别。

相关原文

《伤寒论》12：太阳中风，阳浮而阴弱；阳浮者热自发，阴弱者汗自出；啬啬恶寒，淅淅恶风，翕翕发热，鼻鸣干呕者，桂枝汤主之。

《伤寒论》13：太阳病，头痛，发热，汗出，恶风，桂枝汤主之。

《伤寒论》15：太阳病，下之后，其气上冲者，可与桂枝汤；若不上冲者，不得与之。

《伤寒论》16：桂枝本为解肌，若其人脉浮紧，发热汗不出者，不可与之。

《伤寒论》17：酒客病，不可与桂枝汤，得汤则呕，以酒客不喜甘故也。

《伤寒论》24：太阳病，初服桂枝汤，反烦不解者，先刺风池、风府，却与桂枝汤则愈。

《伤寒论》25：服桂枝汤，大汗出，脉洪大者，与桂枝汤如前法；若形如疟，一日再发者，汗出必解，宜桂枝二麻黄一汤。

《伤寒论》42：太阳病，外证未解，脉浮弱者，当以汗解，宜桂枝汤。

《伤寒论》44：太阳病，外证未解，不可下也；下之为逆，欲外解者，宜桂枝汤。

《伤寒论》45：太阳病先发汗不解，而复下之，脉浮者不愈；今脉浮，故在外，当须解外则愈，宜桂枝汤。

《伤寒论》53：病常自汗出者，此为荣气和，卫气不共荣气谐和故尔；复发其汗，荣卫和则愈，宜桂枝汤。

《伤寒论》54：病人脏无他病，时发热，自汗出而不愈者，此卫气不和也；先其时发汗则愈，宜桂枝汤。

《伤寒论》56：伤寒不大便六七日，头痛有热者，与承气汤；其小便清者，知不在里，仍在表也，当须发汗；若头痛者必衄，宜桂枝汤。

《伤寒论》57：伤寒发汗已解，半日许复烦，脉浮数者，可更发汗，宜桂枝汤。

《伤寒论》91：伤寒医下之，续得下利清谷不止，身疼痛者，急当救里；后身疼痛、清便自调者，急当救表，救表宜桂枝汤。

《伤寒论》95：太阳病，发热汗出者，此为荣弱卫强，故使汗出；欲救邪风者，宜桂枝汤。

《伤寒论》234：阳明病，脉迟，汗出多，微恶寒者，表未解也，可发汗，宜桂枝汤。

《伤寒论》240：病人烦热，汗出则解，又如疟状，日晡所发热；脉浮虚者，宜发汗，发汗宜桂枝汤。

《伤寒论》276：太阴病，脉浮者，可发汗，宜桂枝汤。

《伤寒论》372：下利，腹胀满，身体疼痛者，先温其里，乃攻其表；温里宜四逆汤，攻表宜桂枝汤。

《伤寒论》387：吐利止，而身痛不休者，当消息和解其外，宜桂枝汤小和之。

《金匱要略·妇人妊娠病》：妇人得平脉，阴脉小弱，其人渴，不能食，无寒热，名妊娠，桂枝汤主之。

《金匱要略·妇人产后病》：产后风，续之数十日不解，头微痛，恶寒，时时有热，心下闷，干呕汗出，可与阳旦汤。

医案

（胡希恕经方故事，桂枝汤治定时发热汗出）：一厨师患定时发热汗出二十余年，发作时发热继而汗出，汗后如常人。胡老据“时发热、自汗出”属卫气不和，予桂枝汤，嘱先其时服药取微汗，服后病止。

十二字病理分析：

表虚：定时汗出、汗后如常，是营卫不和、腠理失约，先其时微汗以和营卫。

里虚：病程二十余年，久病而正气不足，需姜枣草扶中化源。

血虚：汗出日久易伤津血，芍药养营敛阴，使汗出不再过度。



桂枝加葛根汤

组成

葛根四两 芍药二两 生姜三两切 甘草二两炙 大枣十二枚擘 桂枝二两

比例

葛根4 桂枝2 芍药2 炙甘草2 生姜3 大枣5

病理

表虚

里热

病理症状

表虚

汗出恶风、项背强几几，营卫不和、腠理不固；项背拘急为太阳经气津液不利，葛根升津舒筋，仍属阳性表虚。

里热

葛根偏清凉解肌，兼可治热利，提示本方较桂枝汤可有轻度里热倾向，但不可见大烦渴、里热炽盛。

易混淆方

葛根汤

桂枝汤

柴胡桂枝汤

桂枝加附子汤

方剂	核心区别
桂枝加葛根汤	太阳表虚兼项背强，汗出恶风、项背强几几。
葛根汤	太阳表实，无汗恶寒、脉浮紧、项背强，有麻黄。
桂枝汤	表虚基础证，汗出恶风，无项背强急。
柴胡桂枝汤	太阳少阳合病，心下支结、微呕、胸胁不舒。
桂枝加附子汤	汗漏阳虚，汗出不止、恶风、小便难、四肢微急。

辨证要点

汗出恶风+项背强几几是核心抓手。

基础必须有桂枝汤证：汗出、恶风、发热头痛、脉浮缓或浮弱。

项强牵连到背，转头、俯仰不利，类似落枕样拘急。

有汗为表虚；若无汗、恶寒重、项背强，则多转葛根汤。

本方不含麻黄；见汗出恶风而误加麻黄，易伤津液。

葛根偏清凉，胃虚腹凉、下利清谷者慎用或需另辨。

颈椎病、面瘫、后项痛等必须见本方证，不可见颈项痛即套方。

若烦躁、口渴、脉洪大、里热突出，不能只按本方处理。

相关原文

《伤寒论》14：太阳病，项背强几几，反汗出恶风者，桂枝加葛根汤主之。

《伤寒论》12：太阳中风，阳浮而阴弱；阳浮者热自发，阴弱者汗自出；啬啬恶寒，淅淅恶风，翕翕发热，鼻鸣干呕者，桂枝汤主之。

《伤寒论》13：太阳病，头痛，发热，汗出，恶风，桂枝汤主之。

《伤寒论》31：太阳病，项背强几几、无汗恶风，葛根汤主之（与本方鉴别：无汗为表实）。

医案

（刘渡舟，口眼歪斜）：女，26岁。乘长途汽车倚窗而睡受风，归后左侧面部肌肉拘紧，口眼向左侧歪斜；脉浮，舌苔白润。辨风邪客于阳明经络，经气不利。处方：桂枝、白芍、生姜、大枣、炙甘草、葛根，加白附子、全蝎。服药二剂，汗出邪去而愈。

十二字病理分析：

表虚：受风后发病，脉浮，方以桂枝汤调营卫，汗出邪去为解表之效。

血虚：络脉空虚，风邪乘虚入络，需桂芍调营血。

气实：面部肌肉拘紧、口眼歪斜，经络气血不利，葛根升津舒筋通络。



桂枝加附子汤

组成

桂枝三两去皮 芍药三两 甘草三两炙 生姜三两切 大枣十二枚擘 附子一枚炮去皮破八片

比例

桂枝3 芍药3 炙甘草3 生姜3 大枣5 附子1

病理

表虚

水虚

阴证

病理症状

表虚

本为桂枝汤证，发汗太过或误汗后**汗漏不止、恶风**。

水虚

小便难、四肢微急、难以屈伸，为汗出过多、肌肉筋脉失濡。

阴证

神疲乏力、畏寒、肢冷、脉弱

易混淆方

桂枝附子汤

麻黄附子细辛汤

白虎汤

四逆汤

方剂	核心区别
桂枝加附子汤	桂枝汤证陷入少阴表虚， 汗漏不止、恶风、小便难、四肢微急 。
桂枝附子汤	风湿表虚偏阴， 身体疼痛、不能自转侧、脉浮虚涩 ，主风湿身痛，不主漏汗。
麻黄附子细辛汤	少阴表实， 恶寒无汗、脉沉、精神沉、寒饮头痛 ，本方则汗出漏汗。
白虎汤	阳明里热大汗， 大汗出、大烦渴、脉洪大 ，不是表虚阴性汗漏。
四逆汤	太阴少阴里虚寒重， 厥逆、下利清谷、脉微欲绝 ，救里回阳为急。

辨证要点

汗漏不止+恶风是第一抓手。

本方是**桂枝汤证陷入阴证/少阴表虚**，不是普通桂枝汤证。

可有发热，也可不发热；关键不在热度，而在**汗漏与机能沉衰**。

若身体疼痛、不能自转侧、风湿痛重，应与桂枝附子汤鉴别。

相关原文

《伤寒论》20：太阳病，发汗，遂**漏不止**，其人**恶风**，**小便难**，**四肢微急**，**难以屈伸**者，桂枝加附子汤主之。

医案

（李冠杰，输液退热后汗漏）：患者发热后输液退烧，发烧和难受症状似已过去，但遗留**喝一口水就出一口汗**，汗后觉冷，需穿衣加衣，精神困乏。辨为退热发汗过度后桂枝加附子汤证。

十二字病理分析：

表虚：**喝水即汗出、汗漏不止**，汗孔收摄失控，营卫不固。

阴性：**汗后觉冷、需要加衣、精神困乏**，机能沉衰，已非普通桂枝汤证。

水虚：汗出过多，津液外亡，肌表筋脉失濡。

里虚：发汗退热后体力下降，胃气津液不足以支持体表。



葛根加半夏汤

组成

葛根四两 麻黄三两去节 甘草二两炙 芍药二两 桂枝二两去皮 生姜二两切 半夏半升洗 大枣十二枚擘

比例

葛根4 麻黄3 桂枝2 生白芍2 炙甘草2 生姜2 半夏12 大枣5

病理

表实

水实

里虚

病理症状

表实

葛根汤证底子，无汗、恶寒、项背强、脉浮紧。

水实

胃中停饮，胃虚水停而呕，半夏去水止呕。

里虚

平素胃功能低下，吸收水分能力差，寒不重，以停饮为主。

易混淆方

葛根汤

桂枝加葛根汤

葛根芩连汤

小半夏汤

小青龙汤

方剂	核心区别
葛根加半夏汤	表实项背强+胃虚停饮呕，无汗恶寒、项背强、呕吐。
葛根汤	表实项背强，无呕或有下利，不加半夏。
桂枝加葛根汤	表虚项背强，汗出恶风、脉浮缓，无麻黄。
葛根芩连汤	表虚+里热下利，喘而汗出、热利、脉数。
小半夏汤	纯胃中停饮呕吐，无表证，半夏+生姜。
小青龙汤	表实+寒饮重，咳喘为主、痰白稀、里寒明显。

辨证要点

葛根汤证而呕者是条文核心。

抓手一：无汗恶寒、项背强、脉浮紧，葛根汤证底子。

抓手二：呕吐、恶心、吐清水，胃虚停饮。

抓手三：胃功能差、食欲不振，即使不呕，也可加半夏。

有汗表虚者用桂枝加葛根汤，不可用本方。

里寒重、完谷不化、四肢厥逆者，不宜单用本方，需合温里方。

相关原文

《伤寒论》33：太阳与阳明合病，不下利，但呕者，葛根加半夏汤主之。

《伤寒论》32（参照）：太阳与阳明合病，必自下利者，葛根汤主之（无呕用葛根汤）。

《伤寒论》31（参照）：太阳病，项背强几几、无汗恶风，葛根汤主之（葛根汤基础方证）。

医案

（刘渡舟，二阳合病）：程某，女，25岁。初春感寒后，发热、头痛、恶风寒、呕吐、面色红赤。脉浮，舌苔白润。证属太阳阳明合病，治用葛根加半夏汤：葛根12g，麻黄6g，桂枝6g，生姜6g，半夏9g，白芍6g，大枣7枚，炙甘草6g。服两剂，汗出身凉，呕吐止而愈。

十二字病理分析：

表实：发热、恶风寒、头痛、脉浮，表邪未解，葛根汤证。

水实：呕吐、舌苔白润，胃中停饮上逆。

里虚：胃功能低下，水饮易停。



柴胡桂枝汤

组成

柴胡四两 桂枝一两半 黄芩一两半 人参一两半 甘草一两炙 半夏二合半 芍药一两半 大枣六枚擘 生姜一两半切

比例

柴胡4 桂枝1.5 黄芩1.5 人参1.5 炙甘草1 半夏2 芍药1.5 大枣6 生姜1.5

病理

表虚

里虚

半热

病理症状

表虚

发热微恶寒、支节烦疼、外证未去，程度较轻。

里虚

食少、胃胀、纳差。

半热

微呕、心下支结、胸胁苦满。

易混淆方

小柴胡汤

桂枝汤

柴胡桂枝干姜汤

大柴胡汤

葛根汤

方剂	核心区别
柴胡桂枝汤	太阳少阳合病， 发热微恶寒、支节烦疼、心下支结、微呕。
小柴胡汤	纯少阳， 胸胁苦满、心烦喜呕、默默不欲饮食 ，无太阳表证。
桂枝汤	太阳表虚， 汗出恶风、脉浮缓 ，无柴胡胸胁证。
柴胡桂枝干姜汤	偏半表半里阴证， 渴而不呕、但头汗出、小便不利。
大柴胡汤	少阳兼里实， 呕不止、心下急、便秘腹满。
葛根汤	表实项背强， 项背强几几、无汗恶寒。

辨证要点

桂枝汤证 + 柴胡证并存，太阳少阳合病。

有少阳证存在时不可单纯发汗，须表里和解同施。

合方可见**定时发作、定时汗出。**

相关原文

《伤寒论》146：伤寒六七日，**发热微恶寒、支节烦疼、微呕、心下支结、外证未去者，柴胡桂枝汤主之。**

《金匱要略·腹满寒疝宿食病》：《外台》柴胡桂枝汤方，治**心腹卒中痛者。**

医案

（李冠杰讲稿，二十年鼻炎）：男，鼻炎二十余年，激光等治疗无效。偶**稍热即汗、刷牙恶心、时烦**，无他病、无阴证、无阳明实。予**柴胡桂枝汤**五天，首剂后**鼻通从未如此痛快**，五年未复发。提示须见方证，非鼻炎特效方。

十二字病理分析：

表虚：**易汗、微恶寒不显**，营卫不和。

半热：**时烦、刷牙恶心**，少阳胃气不和。

半虚：久病体偏虚，合方各半减量。



大陷胸汤

组成

大黄六两去皮 芒硝一升 甘遂一钱匕

比例

大黄6 芒硝16 甘遂1

病理

里实

里热

半热

水实

病理症状

里实

心下痛、按之石硬，拒按明显。

里热

舌上燥而渴、日晡所小有潮热、烦躁、心胸大烦。

半热

胸胁水热互结，外无大热或但头汗出，兼见心中懊憹、短气躁烦。

水实

胸膈痞满、短气、不能平卧、但头微汗出

易混淆方

小陷胸汤

大柴胡汤

大承气汤

十枣汤

方剂	核心区别
大陷胸汤	水热互结，心下至少腹硬满痛、拒按、项强如柔痉。
小陷胸汤	痰热结胸较轻，心下按之则痛、黄连半夏瓜蒌。
大柴胡汤	少阳兼里实，胸胁苦满、心下急、呕不止。
大承气汤	阳明燥实，腹满便硬、潮热谵语，不以水结胸为主。
十枣汤	悬饮水结胁下，咳唾引痛、心下痞硬满，无热实攻下结构。

辨证要点

主抓手：心下至少腹硬满而痛不可近，或心下痛按之石硬。

必须同时找里热/里实证据：舌燥而渴、便秘、潮热、烦躁、苔黄燥、脉沉紧有力。

必须同时找水结证据：胸胁痞闷、短气、不能平卧、但头微汗出、胸腹积水或痰涎水饮壅结。

无少阳证是与大柴胡汤的重要边界；若往来寒热、胸胁苦满明显，应先考虑大柴胡汤。

只是心下满而不痛，多属痞证，宜半夏泻心汤类，不可误下。

正在心下、按之则痛、病位浅小，多属小陷胸汤；大陷胸汤病势更深、更广、更急。

本方为峻剂，甘遂有毒，非实热水结、拒按石硬者不可轻用。

若阴证、脏结、舌白滑、饮食如故时时下利，属不可攻边界。

相关原文

《伤寒论》134：太阳病，脉浮而动数，头痛发热，微盗汗出，而反恶寒者，表未解也；医反下之，动数变迟，膈内拒痛，短气躁烦，心中懊憹，阳气内陷，心下因硬，则为结胸，大陷胸汤主之。若不大结胸，但头汗出，余处无汗，剂颈而还，小便不利，身必发黄也，宜大陷胸丸。

《伤寒论》135：伤寒六七日，结胸热实，脉沉而紧，心下痛，按之石硬者，大陷胸汤主之。

《伤寒论》136：伤寒十余日，热结在里，复往来寒热者，与大柴胡汤；但结胸无大热者，此为水结在胸胁也，但头微汗出者，大陷胸汤主之。

《伤寒论》137：太阳病，重发汗而复下之，不大便五六日，舌上燥而渴，日晡所小有潮热，发心胸大烦，从心下至少腹，硬满而痛，不可近者，大陷胸汤主之。

《伤寒论》138：少结胸者，正在心下，按之则痛，脉浮滑者，小陷胸汤主之。此为大陷胸汤的重要鉴别条文。

《伤寒论》149：伤寒五六日，呕而发热者，柴胡汤证具；若误下后心下满而硬痛者，此为结，大陷胸汤主之；但满而不痛者，此为痞，柴胡不中与之，宜半夏泻心汤。

医案

曹颖甫《经方实验录》大陷胸汤证。患者陈姓男孩，14岁，骤病；见脉洪大、大热、口干、自汗，右足伸屈不利，胸部如塞，按之似痛，不胀不硬；大便五日未通，口渴但终日不欲饮水。曹氏辨为上膈湿痰与阳明燥热同病，处大陷胸汤：制甘遂4.5g，大黄9g，芒硝6g。服后大便畅通，燥屎与痰涎先后俱下，诸症霍然。

十二字病理分析：

半热：胸部如塞、湿痰在上，病位牵涉胸膈。

里热：脉洪大、大热、口干、自汗，阳明热象明显。

里实：大便五日未通，下焦燥结。

水实：口渴但终日不欲饮水



大黄附子汤

组成

大黄三两 附子三枚炮 细辛二两

比例

大黄3 附子3 细辛2

病理

里实

里寒

水实

血实

阴证

病理症状

里实

固定疼痛；可兼便秘、腹满、绞痛难忍。

里寒

腹底冷寒、脏寒、胁下偏痛。

水实

偏侧痛，下肢浮肿

血实

痛有定处；

阴证

机能沉衰，身冷恶寒、精神不足。

易混淆方

大承气汤

麻子仁丸

大柴胡汤

方剂	核心区别
大黄附子汤	寒实、偏侧痛、胁下偏痛、脉紧弦。
大承气汤	阳明里实热，腹满痛拒按、潮热谵语、大便硬。
麻子仁丸	津枯肠燥、脾约，大便硬但攻下力不宜太猛。
大柴胡汤	少阳兼里实，胸胁苦满、心下急、呕不止。

辨证要点

胁下偏痛、脉紧弦是条文核心，不可只看便秘。

病机是寒实于里，以温药下之，不是阳明燥热承气证。

偏侧痛很关键：胁下、腰腿、坐骨神经样痛、骨刺压迫样一侧痛，都可作为本方线索。

大黄在本方中随附子、细辛而走，重点是温下寒实，不是单纯清热攻下。

相关原文

《金匮要略·腹满寒疝宿食病》：胁下偏痛，发热，其脉紧弦，此寒也，以温药下之，宜大黄附子汤。

医案

（李冠杰常用经方讲解，顽固便秘兼偏侧痛）：女，年轻时因工作环境如厕不便，长期控制饮食少喝水，遗留顽固便秘，多年不愈，诸通便药初服稍效，久则无效。细问可见有时一侧大腿疼痛，平素精神不足，有里寒倾向。辨为寒实偏注兼便秘，又兼柴胡证，取大黄附子汤思路合大柴胡汤，治疗后多年未复发。

病理分类分析：

阴证：精神不足、里寒倾向，病性偏阴寒。

里寒：久病寒实，非阳明燥热便秘。

里实：顽固便秘，通便药短效，寒实结聚不去。

水实：一侧大腿痛可作寒湿偏注线索，细辛、附子温散寒湿。

血实：偏侧固定痛日久，可兼久寒夹瘀。



柴胡加芒硝汤

组成

柴胡二两十六铢 黄芩一两 人参一两 甘草一两炙 生姜一两切 半夏二十铢 大枣四枚擘 芒硝二两

比例

柴胡8 黄芩3 人参3 炙甘草3 生姜3 半夏3 大枣5 芒硝3

病理

里实

里热

半热

病理症状

里实

潮热者实也；可见大便硬、腹满、腹痛拒按，或热利而里实未除。

里热

日晡所发潮热、舌红、苔厚燥、口干、小便短黄，阳明热已入里。

半热

见胸胁满、喜呕、口苦、心烦、寒热往来。

易混淆方

小柴胡汤

大柴胡汤

大承气汤

调胃承气汤

方剂	核心区别
柴胡加芒硝汤	少阳未解兼轻里实，胸胁满、日晡潮热、微利或便秘。
小柴胡汤	少阳证而无里实，心烦喜呕、胸胁苦满，不需芒硝软坚。
大柴胡汤	少阳兼里实更重，心下急、按之满痛、呕不止。
大承气汤	阳明燥实重，腹满痛拒按、潮热谵语、大便硬，无少阳主轴。
调胃承气汤	胃家燥热，蒸蒸发热、心烦、大便硬，少阳胸胁证不突出。

辨证要点

第一抓手：胸胁满而呕 + 日晡所发潮热，少阳证与阳明里热实同时存在。

第二抓手：大便硬、大便难，或微利但仍有潮热腹满；微利多按热利或误下后余实理解。

治疗顺序：先小柴胡汤以解少阳，后柴胡加芒硝汤清里热、软坚通便。

芒硝证重点不只是便秘，而是潮热、里热实、燥结未除。

相关原文

《伤寒论》104：伤寒十三日不解，胸胁满而呕，日晡所发潮热，已而微利。此本柴胡证，下之以不得利；今反利者，知医以丸药下之，此非其治也。潮热者，实也。先宜服小柴胡汤以解外，后以柴胡加芒硝汤主之。

医案

（现代临床医案，功能性便秘）：患者女，半月前淋雪受凉后起病，初有恶寒发热、咯稀白痰，服药后表证暂缓。十日前转为怕热、持续低热、午后热势加重，兼口苦咽干、唇燥面垢、腹胀纳差、便干难行、小便短黄，舌燥苔黄，脉弦迟。辨为外感后邪入少阳，少阳枢机不利，又传阳明成里热实，予柴胡加芒硝汤加减并配合中脘、神阙悬空灸。二诊热势下降，便秘减轻，舌质渐润；继服后随访热退便通。

十二字病理分析：

半热：怕热、低热午后加重、口苦咽干，少阳郁热明显。

半虚：病程迁延，服药后表证未彻底解，正气受损，所以用小柴胡汤底子顾护中气。

里热：午后热势加重、唇燥、舌燥苔黄、小便短黄，热入阳明。

里实：腹胀、便干难行，阳明腑气不通，燥结未甚但已成实。

辨方关键：此案不是单纯便秘，而是少阳证未解 + 阳明里热实便难，所以合柴胡加芒硝汤意。



四逆散

组成

甘草炙 枳实破水渍炙干 柴胡 芍药各十分

比例

柴胡3 生白芍3 枳实3 炙甘草3

病理

里实

半热

血虚

气实

病理症状

里实

枳实、芍药主心下与腹部实满拘急，见心下满痛、腹中痛、腹胀、泄利下重或便秘。

半热

柴胡证为本，见胸胁苦满、往来寒热、口苦心烦、脉弦；四逆多为热壅气郁所致的假寒外观。

血虚

芍药合甘草养血缓急，处理腹挛痛、筋脉拘急、腹壁痛，使气郁里实不致单纯攻下。

气实

柴胡合枳实行气解郁，主胸胁满、暖气、腹胀、乳房胀痛、气机不舒。

易混淆方

四逆汤

大柴胡汤

小柴胡汤

柴胡桂枝汤

芍药甘草汤

方剂	核心区别
四逆散	少阳气郁兼轻里实，四逆、腹痛、泄利下重、不可下。
四逆汤	真寒阴证，下利清谷、脉微欲绝、四肢厥冷。
大柴胡汤	少阳兼里实可下，心下急、按痛、呕不止、便秘。
小柴胡汤	少阳虚热，胸胁苦满、心烦喜呕，无腹痛拘急为主。
柴胡桂枝汤	太阳少阳合病，发热微恶寒、支节烦疼。
芍药甘草汤	单纯拘急痛，脚挛急、肌肉痉挛，无柴胡证。

辨证要点

第一抓手是柴胡证加心下或腹部实满痛，不是见四肢冷就用。

大柴胡汤证不可下者是重要边界：有胸胁苦满、心下抵抗，但大便不硬或反偏溏。

腹痛、泄利下重而兼胸胁苦满、脉弦者，可从四逆散考虑。

胃痛、心下按之不喜按、抵抗感明显，而无明显寒饮虚寒证，是常见入口。

若心下急硬、呕不止、便秘明显，偏大柴胡汤；若单纯胸胁苦满、喜呕、里实不显，偏小柴胡汤。

相关原文

《伤寒论》318：少阴病，四逆，其人或咳，或悸，或小便不利，或腹中痛，或泄利下重者，四逆散主之。

医案

（李冠杰讲稿，肺结核久病后胃痛腹满）：男，长期肺结核病史，病程迁延，近来咳嗽不重，但有喘、短气，上腹部满，胃部疼痛。大便有时一日两次。腹诊见心下明显抵抗、按之满甚、不喜按，自诉疼痛在腹壁浅层。辨为有柴胡证背景，现转为实，且不可下，不能用大柴胡汤，兼芍药甘草汤证。予四逆散约十余克，次日反馈昨晚服一次后“感觉全好了”。

十二字病理分析：

半热：久病中反复出现柴胡证背景，现仍有半表半里不和。

里实：上腹满、心下抵抗、不喜按，提示里实而未到可攻下程度。

气实：胃脘满闷、喘短气、胸腹气机不舒，是气郁不畅。

血虚：腹壁浅层痛、腹肌拘急，对应芍药甘草缓急止痛。



白虎加桂枝汤

组成

知母六两 甘草二两炙 石膏一斤 粳米六合 桂枝三两去皮

比例

知母18 炙甘草6 石膏50 粳米30 桂枝9

病理

表虚

里热

病理症状

表虚

骨节疼烦，表邪未解

里热

身无寒但热、温疟，
内热欲出而外束，汗
出不畅则热郁。

易混淆方

白虎汤

桂枝芍药知母汤

越婢加术汤

麻杏石甘汤

方剂	核心区别
白虎加桂枝汤	里热炽盛兼表/经络不和， 身热、骨节疼烦、时呕或 汗出。
白虎汤	纯阳明里热，大热、大 汗、大渴、脉洪大，无骨 节疼烦、无桂枝证。
桂枝芍药知母汤	历节寒湿水肿夹热，脚肿 如脱、头眩短气、欲吐。
越婢加术汤	风水身肿，续自汗出、身 肿、小便不利、里热更突 出。
麻杏石甘汤	肺热喘咳为主，汗出而 喘，非骨节热痹为主。

辨证要点

桂枝甘草汤证又见白虎汤证，太阳阳明合病、表里并病。

无往来寒热、胸胁苦满等柴胡证时，方为本方机会。

纯白虎证（无骨节疼、无呕）用白虎汤；渴甚津伤用白虎加人参。

见于急慢性关节炎、感冒、疟疾、热痹等。

相关原文

《金匱要略·疟病脉证并治》：温疟者，其脉如平，身无寒但热，骨节疼烦，时呕，白虎加桂枝汤主之。

《金匱要略·疟病》：脉弦数者，多热；温疟与瘧但热不寒相应。

医案

（新加坡中医杂志，严某热痹）：严某，女，35岁，1996年初诊。诊为痹证（热痹），西医骨关节炎。症见关节肿痛、发热，ESR升高，类风湿因子阴性。治宜清热止痛，予白虎加桂枝汤加味：石膏30、知母10、炙甘草5、桂枝15、川牛膝15、威灵仙15、虎杖15、丹皮10、赤芍15、鬼箭羽30、粳米12。连服14剂，诸症皆除，ESR正常。

十二字病理分析：

里热：发热、关节红肿热痛，热痹壅滞。

表虚：骨节疼烦，经络痹阻。

血实：久病瘀热，加牛膝赤芍虎杖通络。



黄芪桂枝五物汤

组成

黄芪三两 芍药三两 桂枝三两 生姜六两 大枣十二枚

比例

黄芪3 芍药3 桂枝3 生姜6 大枣5

病理

表虚

里虚

血虚

病理症状

表虚

汗出，恶风，脉虚弱

里虚

脉虚弱，乏力，面色不华

血虚

皮肤如隔一层物、知觉迟钝。

易混淆方

桂枝加黄芪汤

当归芍药散

桂枝附子汤

甘草附子汤

方剂	核心区别
黄芪桂枝五物汤	血痹身体不仁，麻木隔物感、恶风、脉微弱。
桂枝加黄芪汤	黄汗表虚，黄汗、汗出恶风、身重，主黄汗不主麻木。
当归芍药散	血虚水盛，腹痛拘急、头晕心悸、小便不利、肢麻，水血证更明显。
桂枝附子汤	风湿表虚偏寒，身体疼痛、不能自转侧、恶风寒，疼痛重于麻木。
甘草附子汤	虚寒湿痹剧痛，骨节疼痛、掣痛不得屈伸、小便不利。

辨证要点

摸皮肤像隔着一层东西，像不是自己的

血痹不是单纯瘀血攻逐证，而是表虚、里虚、血脉失养兼痹阻。

麻木可兼轻痛，但若疼痛剧烈、掣痛不得屈伸，应转甘草附子汤、桂枝芍药知母汤等鉴别。

黄芪用于体表虚衰，不是所有气虚、肺虚都可套用。

相关原文

《金匮要略·血痹虚劳病》：血痹，阴阳俱微，寸口关上微，尺中小紧，外证身体不仁，如风痹状，黄芪桂枝五物汤主之。

医案

（李冠杰临床）：患者半边身子麻木，表现为皮肤知觉不灵敏，摸着像隔着一层东西，不是电击样麻嗖嗖。辨为黄芪桂枝五物汤证，主要用本方治疗，服一段时间后麻木痊愈。

十二字病理分析：

表虚：肌肤知觉迟钝、外部营养不足，黄芪实表外达。

里虚：脉证偏虚，胃气不足以充养体表。

血虚：半身麻木、身体不仁，血脉肌肤失养。



苓桂术甘汤

组成

茯苓四两 桂枝三两去皮 白术二两 甘草二两炙

比例

炙甘草2 桂枝3 苍术2 茯苓4

病理

表虚

里寒

里虚

水实

气实

病理症状

表虚

本方由桂枝甘草汤加茯苓、白术而成，仍有**表虚未解、气从表解之势**；可见汗出、身潮、轻微发热。

里寒

水饮属寒，脉沉紧、苔白滑，兼**形寒肢冷、便溏、胃中寒饮**者更明显。

里虚

吐下后伤胃，胃气虚则水停心下；见**纳呆、神疲、胃中停水、心下逆满**。

水实

心下有痰饮、起则头眩、胸胁支满、小便不利，胃中停水上犯头胸。

气实

心下逆满、气上冲胸、短气、心悸，水饮挟气上冲。

易混淆方

五苓散

真武汤

茯苓甘草汤

苓桂枣甘汤

吴茱萸汤

泽泻汤

方剂	核心区别
苓桂术甘汤	水饮上冲， 心下逆满、气上冲胸、起则头眩、脉沉紧 。
五苓散	水实气化不利， 小便不利、渴欲饮水、水入则吐、头眩心悸 ，渴和小便不利更突出。
真武汤	阴性水饮， 头眩心悸、身瞤动、振振欲擗地、形寒肢冷 ，机能沉衰更重。
茯苓甘草汤	胃中停水， 心下悸、四肢厥、口不渴 ，头眩不如本方突出。
苓桂枣甘汤	脐下悸欲作奔豚， 少腹悸动、气从少腹上冲 ，不以心下逆满头眩为主。
吴茱萸汤	胃寒饮逆， 食谷欲呕、吐涎沫、巅顶头痛、手足厥冷 ，呕吐寒逆更突出。
泽泻汤	支饮眩冒， 苦冒眩、头重如裹 ，无明显气上冲胸。

辨证要点

心下逆满 + 气上冲胸 + 起则头眩是本方核心组合。

脉沉紧提示里有水饮；苔白滑、齿痕、胃中振水声可作佐证。

头晕不是单独用方依据，必须有**水饮停于心下**或气冲证据。

短气有微饮，当从小便去之，短气、胸闷、心悸可由微饮上冲而来。

表证夹停饮时不可单纯发汗，利水降冲后表可自解。

无气冲之候者效果差；心下逆满、胸胁支满、气上冲咽喉皆属气冲证据。

恶心呕吐、吐涎沫、巅顶头痛明显者，多偏吴茱萸汤。

口渴欲饮、小便不利、水入则吐明显者，多偏五苓散。

相关原文

《伤寒论》67：伤寒若吐若下后，**心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉沉紧**，发汗则动经，身为振振摇者，茯苓桂枝白术甘草汤主之。

《伤寒论》160：伤寒吐下后，发汗，虚烦，脉甚微，八九日**心下痞硬、胁下痛、气上冲咽喉、眩冒、经脉动惕**者，久而成痿。

《金匱要略·痰饮咳嗽病》：**心下有痰饮，胸胁支满，目眩**，苓桂术甘汤主之。

《金匱要略·痰饮咳嗽病》：夫**短气有微饮，当从小便去之**，苓桂术甘汤主之；肾气丸亦主之。

医案

（李冠杰讲稿）：男，三十多岁，感冒两天，稍有发热，没劲，**头晕明显**，身上潮乎乎；既往脑部手术后逐渐发胖，形体呈不正常浮肿样。辨为表证夹停饮，予苓桂术甘汤四味。三日后反馈：服后**感冒与头晕好转**。

十二字病理分析：

表虚：**稍有发热、身上潮乎乎**，表未尽解而非峻表实。

里虚：术后体态浮肿、没劲，提示正气与运化不足。

水实：**不正常发胖、浮肿样、头晕明显**，水饮上犯清阳。

气实：头晕伴表未解，水饮挟气上冲，故用桂枝甘草降冲。



苓桂枣甘汤

组成

茯苓半斤 甘草二两炙 大枣十五枚擘 桂枝四两去皮

比例

茯苓8 桂枝4 甘草2 大枣6

病理

表虚

里虚

水实

气实

病理症状

表虚

可见汗出、恶风、脉浮等表虚背景。

里虚

腹挛急、少腹拘急、心悸不安，属虚中夹实。

水实

脐下悸、小便不利、少腹水饮欲动。

气实

气从少腹上冲心胸咽喉，欲作奔豚。

易混淆方

苓桂术甘汤

茯苓甘草汤

桂枝加桂汤

奔豚汤

五苓散

真武汤

方剂	核心区别
苓桂枣甘汤	少腹水气上冲， 脐下悸、欲作奔豚、气从少腹上冲 ，重在下焦水饮悸动。
苓桂术甘汤	水饮上冲胸膈， 心下逆满、气上冲胸、起则头眩 ，头眩心下逆满更突出。
茯苓甘草汤	胃中停水， 心下悸、四肢厥、口不渴 ，悸在心下，不在脐下。
桂枝加桂汤	气上冲为主， 气从少腹上冲心 ，但无明显水饮、小便不利、脐下悸。
奔豚汤	奔豚已作， 气上冲胸、腹痛、往来寒热、烦躁较重 ，偏半表半里热与气血郁滞。
五苓散	水实气化不利， 小便不利、渴欲饮水、水入则吐 ，口渴和尿不利更突出。
真武汤	阴性水饮， 心悸头眩、身瞤动、振振欲擗地、形寒肢冷 ，机能沉衰更重。

辨证要点

脐下悸是本方最核心、最有特异性的抓手。

欲作奔豚不是已经严重奔豚，而是少腹气水将要上冲的状态。

气上冲的路线多从**少腹上冲心胸、咽喉或头顶**，常伴心悸惊恐。

必须有水饮证据：**小便不利、苔白腻、少腹悸动、胃脘停水感**。

本方与苓桂术甘汤相近，但不以**心下逆满、起则头眩**为主。

本方与茯苓甘草汤相近，但茯苓甘草汤多为**心下悸、胃中停水、四肢厥**。

相关原文

《伤寒论》第65条：发汗后，其人**脐下悸者，欲作奔豚**，茯苓桂枝甘草大枣汤主之。

《金匱要略·奔豚气病》：发汗后，**脐下悸者，欲作奔豚**，茯苓桂枝甘草大枣汤主之。

医案

（石建华教授，寒水上逆反酸案）：刘某，男，32岁。五年前运动后一口气喝大瓶可乐，数小时后剧烈腹痛，自觉**脐下有气向上冲**，剧烈呕吐，热敷缓解。此后间断发作**脐下悸动，旋即逆气上冲**，口中酸水泛滥，伴胃脘胀闷不舒、心慌不安、形寒肢冷；近二个月频繁发作。舌苔白腻，脉弦紧。西医诊为反流性食道炎。辨为寒水上逆，治以温阳行水、理气降逆，用茯苓桂枝甘草大枣汤加吴茱萸、半夏、生姜，7剂后愈。

十二字病理分析：

水实：**脐下悸动、苔白腻、酸水泛滥**，寒水内停上逆。

气实：**脐下有气向上冲、胃脘胀闷、心慌不安**，气逆上冲。

里寒：**形寒肢冷、脉弦紧**，寒水上逆背景。

里虚：久病反复，胃阳不足，水饮不化。

表虚：虽非发汗后发病，但方义仍取桂枝甘草通阳降冲、调表里。



桂枝加黄芪汤

组成

桂枝三两 芍药三两 甘草二两炙 生姜三两 大枣十二枚 黄芪二两

比例

桂枝3 芍药3 炙甘草2 生姜3 大枣5 黄芪2

病理

表虚

里虚

水实

病理症状

表虚

汗出、恶风

里虚

久汗、暮盗汗、不能食、

水实

身重、汗出已辄轻、小便不利、如有物在皮中状

易混淆方

黄芪桂枝五物汤

麻黄连翘赤小豆汤

茵陈蒿汤

防己黄芪汤

方剂	核心区别
桂枝加黄芪汤	桂枝汤证更见表虚黄汗， 黄汗、汗出恶风、身重汗后轻、小便不利 。
黄芪桂枝五物汤	血痹身体不仁， 麻木隔物感、恶风、脉微弱 ，主麻木不主黄汗。
麻黄连翘赤小豆汤	表实湿热发黄， 无汗、发热恶寒、身黄或身痒、小便黄赤 。
茵陈蒿汤	阳明湿热黄疸， 身黄如橘子色、腹微满、小便不利 ，表虚汗出不是主轴。
防己黄芪汤	风水表虚湿重， 身重、汗出恶风、下肢水肿 ，可有汗出身重，但无黄汗为核心。

辨证要点

黄汗病：出汗、发热、身肿痛

黄芪在本方是补表气、助桂枝汤解表虚水湿，不是见气虚就加。

相关原文

《金匱要略·水气病》：黄汗之病，两胫自冷；假令发热，此属历节。食已汗出，又身常暮盗汗出者，此劳气也；若汗出已，反发热者，久久其身必甲错；发热不止者，必生恶疮。若**身重，汗出已辄轻者**，久久必身瞤。瞤即胸中痛，又从**腰以上必汗出，下无汗，腰髀弛痛，如有物在皮中状**，剧者不能食，**身疼重，烦躁，小便不利**，此为黄汗，**桂枝加黄芪汤主之**。

《金匱要略·黄疸病》：诸病黄家，但利其小便；假令**脉浮，当以汗解之**，宜**桂枝加黄芪汤主之**。方见水气病中。

医案

（胡希恕，黄汗）：一妇人，曾被诊为肝硬变，面目褐黄而非典型黄疸，腰痛甚，来诊需人搀扶。胡老见其衣领黄染，询问得知**出黄汗**，遂不再按肝硬变方向处理，改用桂枝加黄芪汤。服后**黄汗基本解决，腰痛减轻，后来可自行来诊**，整体状态好转。

十二字病理分析：

表虚：**出黄汗、衣领黄染**，汗出异常而肌表不固，需黄芪助桂枝汤实表。

水实：**腰痛甚、黄汗**，水湿郁于肌表筋肉，汗出而黄。

里虚：久病体虚，行动需人搀扶，正气不足以运化水湿。



桂枝人参汤

组成

桂枝四两别切 甘草四两炙 白术三两 人参三两 干姜三两

比例

桂枝4 炙甘草4 白术3 人参3 干姜3

病理

表虚

里寒

里虚

病理症状

表虚

发热恶寒、头痛、汗出

里寒

利下不止、清稀不臭、腹冷喜温。

里虚

心下痞硬、纳差乏力、脉沉迟或弱。

易混淆方

理中汤

葛根芩连汤

半夏泻心汤

生姜泻心汤

黄芩汤

方剂	核心区别
桂枝人参汤	太阳太阴合病，外证未除、下利不止、心下痞硬、表里不解。
理中汤	纯太阴里虚寒，腹冷痛、吐利、口不渴、脉沉迟，无明显外证未除。
葛根芩连汤	表未解兼里热下利，下利臭秽、肛门灼热、口渴苔黄、喘汗。
半夏泻心汤	寒热错杂痞利，心下痞、呕而肠鸣、下利，有黄芩黄连之热象。
生姜泻心汤	水饮食臭痞利，干噎食臭、胁下水气、腹中雷鸣下利。
黄芩汤	少阳热利腹痛，下利腹痛、口苦发热、热象较明。

辨证要点

第一个抓手：下利不止，且偏虚寒，清稀不臭、腹冷、喜温。

第二个抓手：心下痞硬，是胃虚中寒后心下部痞塞拘硬，不是硬痛拒按。

第三个抓手：外证未除、表里不解，仍有发热恶寒、头痛、汗出或表证未尽。

“协热利”在本方不能等同于湿热利；若见臭秽黏滞、肛门灼热、口渴苔黄，应考虑葛根芩连汤。

若心下痞硬而恶寒表未解，条文提示不可攻痞，当先解表。

相关原文

《伤寒论》第163条：太阳病，外证未除，而数下之，遂协热，而利下不止，心下痞硬，表里不解者，桂枝人参汤主之。

《伤寒论》第164条：伤寒大下后，复发汗，心下痞，恶寒者，表未解也，不可攻痞，当先解表；表解乃可攻痞。

医案

(临床场景示例，感冒后寒凉误治)：患者感冒发热后自服清热泻火药，热势不退反见腹泻日数次、便清稀、胃脘痞硬，仍恶寒头痛，口不渴，舌淡苔白滑，脉虚缓。辨为表证未解，寒凉伤中，太阳太阴合病，宜桂枝人参汤加減。

十二字病理分析：

表虚：恶寒头痛、表证仍在。

里寒：便清稀、口不渴、舌苔白滑，寒利明显。

里虚：胃脘痞硬、脉虚缓，中气受损。



竹叶汤

组成

竹叶一把 葛根三两 防风一两 桔梗一两 桂枝一两 人参一两 甘草一两 附子一枚炮 大枣十五枚 生姜五两

比例

竹叶1把 葛根3 防风1 桔梗1 桂枝1 人参1 炙甘草1 附子1 大枣15枚 生姜5

病理

表虚

阴性

里热

里虚

气逆

血虚

病理症状

表虚

产后气血不足，复中风邪，见**发热、头痛、恶风寒**倾向；方中桂枝、防风、葛根解表，温覆使汗出，说明仍有表证。

阴性

产后大虚，方中用**附子、人参、姜枣草**，提示机能沉衰、正气不足，不能按普通阳性表证发汗处理。

里热

发热、面正赤，竹叶清热，说明虚弱背景中兼有热象；但不是大青龙、麻杏石甘汤那种实热壅盛。

里虚

产后气血未复，方用**人参、甘草、大枣、生姜**扶中益气；虚是本方能否成立的重要边界。

气逆

喘而头痛，桔梗开提肺气，生姜降逆，说明外邪与虚热上扰，肺气上逆。

血虚

产后失血耗津，气血未复，表里皆虚；血虚不是本方直接补血，而是**产后大虚、筋脉肌表失养**的背景。

易混淆方

大青龙汤

麻杏石甘汤

桂枝汤

桂枝加附子汤

竹叶石膏汤

白虎加人参汤

方剂	核心区别
竹叶汤	产后或大虚背景， 表证+里热+里虚+阴性+气逆 ，发热面赤喘头痛。
大青龙汤	表实里热， 无汗、恶寒发热、烦躁、身疼、脉浮紧 ，体质不虚。
麻杏石甘汤	肺热气逆， 汗出而喘、口渴、里热明显 ，无产后大虚阴性。
桂枝汤	普通表虚， 发热汗出恶风 ，无面赤喘、里热阴性并见。
桂枝加附子汤	表虚陷阴， 汗漏不止、恶风、小便难、四肢微急 ，无明显面赤里热。
竹叶石膏汤	大病后里虚热， 虚羸少气、气逆欲吐、口渴烦热 ，不以表证中风为主。
白虎加人参汤	阳明里热津伤， 大热、大汗、大渴、脉洪大而虚 ，没有表证恶风头痛主轴。

辨证要点

产后或大虚背景是本方成立的前提。

发热、面正赤、喘而头痛是原文抓手。

既有表证，又有里热，但不能按实热表证发汗攻散。

方中有附子、人参、姜枣草，说明必须看到**阴性与里虚**。

竹叶清热，葛根、防风、桂枝解表，桔梗宣肺，体现**清热、解表、扶虚、降逆并用**。

颈项强者原方提示可用大附子；呕者可加半夏。

若无虚象、无阴性，单纯高热面赤喘，应先辨大青龙汤、麻杏石甘汤、白虎汤等。

若只有产后汗出恶风而无面赤喘热，可偏桂枝汤、桂枝加附子汤等方向。

胡希恕提示本条可能有错简，整理时应以**方药病理与临床方证**互参，不可死扣字面。

相关原文

《金匱要略·妇人产后病》：产后，**中风发热，面正赤，喘而头痛**，竹叶汤主之。

方后：竹叶一把，葛根三两，防风、桔梗、桂枝、人参、甘草各一两，附子一枚炮，大枣十五枚，生姜五两。右十味，以水一斗，煮取二升半，分温三服，**温覆使汗出**。颈项强，用大附子一枚，破之如豆大，煎药汤去沫；呕者，加半夏半升，洗。

医案

（李冠杰，重病恢复期特殊感冒）：一女性患者，曾有严重心脏病、高血压、肝胆病、肾病，医院认为治疗困难。后长期经方调治，身体明显好转，能外出活动，但体质仍虚。某阶段出现**很特殊的感冒症状**，不是普通实证外感，李冠杰辨为虚人表证兼里热气逆一类，曾用竹叶汤，服后**效果不错**。

十二字病理分析：

表虚：**特殊感冒症状**，病在表而体质虚弱，不能用强发汗。

阴性：长期重病、心率偏低、体质虚，提示机能沉衰背景。

里虚：久病后正气不足，需人参、姜枣草扶中。

里热：身体好转后出现偏热反应，竹叶清热。

气逆：竹叶汤原文有**喘而头痛**，本方以桔梗、生姜处理上逆。



桂枝新加汤

组成

桂枝三两去皮 芍药四两 甘草二两炙 人参三两 大枣十二枚擘 生姜四两切

比例

桂枝3 芍药4 炙甘草2 人参3 大枣5 生姜4

病理

表虚

里虚

水虚

病理症状

表虚

汗出恶风或表未解。

里虚

脉沉迟、胃气沉衰、心下痞硬。

水虚

发汗后津液不足、身疼痛、筋肉失养。

易混淆方

桂枝汤

桂枝加附子汤

黄芪桂枝五物汤

方剂	核心区别
桂枝新加汤	桂枝汤证兼汗后津血虚，发汗后身疼痛、脉沉迟、胃气虚衰。
桂枝汤	普通太阳中风表虚，发热汗出恶风、脉浮缓，无脉沉迟、津液虚身痛主轴。
桂枝加附子汤	表虚陷阳，汗漏不止、恶风、小便难、四肢微急，寒象与阳虚更重。
黄芪桂枝五物汤	血痹不仁，身体麻木、不仁如隔物、脉微涩，不以汗后身痛脉沉迟为主。

辨证要点

桂枝汤证 + 津液虚 + 胃气虚 + 身疼痛。

身痛不是表实闭郁，而是津血不足、筋肉失养，所以不能再用麻黄类强发汗。

脉沉迟提示里虚、胃气沉衰，是与普通桂枝汤身痛的关键区别。

相关原文

《伤寒论》62：发汗后，身疼痛，脉沉迟者，桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤主之。

医案

（刘渡舟，产后身痛）：樊某，女。产后半月许，忽然身体疼痛，脉来沉迟，无感冒可言。学员辨为气血两虚，用十全大补汤，虽有小效但不彻底。刘渡舟改用桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤：桂枝9克，白芍12克，生姜12克，大枣12枚，炙甘草6克，党参12克。服药三剂后，疼痛消除。

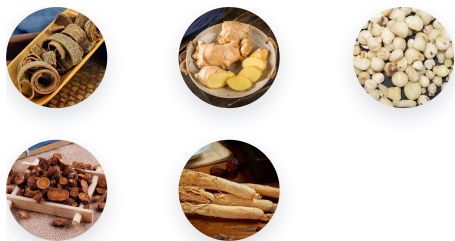
十二字病理分析：

血虚：产后半月、身痛，亡血后营血不足，不能充养肢体。

水虚：身体疼痛、脉沉迟，津血亏虚，筋肉失养。

里虚：脉沉迟，胃气与中气不足，十全大补虽补但外达不足。

表虚：桂枝汤调营卫，使补益之力达于肌表，身痛得解。



厚朴生姜半夏甘草人参汤

组成

厚朴半斤去皮 生姜半斤切 半夏半升洗 甘草二两 人参一两

比例

厚朴8 生姜8 半夏5 甘草2 人参1

病理

里虚

气实

病理症状

里虚

神疲乏力，脉弱舌淡，食后不消化

气实

腹胀满，食后加重，暖气

易混淆方

大承气汤

小承气汤

半夏厚朴汤

茯苓饮

方剂	核心区别
厚朴生姜半夏甘草人参汤	虚胀，腹胀满、按之不坚、不甚痛、食后加重。
大承气汤	实胀，腹满硬痛拒按、大便不通、潮热谵语。
小承气汤	里实较轻，腹满便硬、谵语或潮热较轻。
半夏厚朴汤	痰气咽阻，咽中如有炙脔、胸闷气郁。
茯苓饮	胃虚停饮，胸中有停痰宿水、吐水、食后胀。

辨证要点

腹胀满，虚胀为特征

腹胀按之不坚，不甚痛，时轻时重

虚人腹胀，食后或下午加重

行气药量重于补气药，消大于补

若腹满坚痛拒按、不大便，非本方所宜

相关原文

《伤寒论》第66条：发汗后，腹胀满者，厚朴生姜半夏甘草人参汤主之。

医案

胡希恕医案：胡老曾治一男性患者，感冒后自服发汗药，汗出表解。但随后出现腹胀满，自服多种消导药不效。诊见：腹胀满，按之不坚，不痛，时轻时重，食后及下午加重，伴暖气、纳差、神疲乏力。舌淡苔白，脉弱。辨为发汗后脾虚气滞，予厚朴生姜半夏甘草人参汤：厚朴24g，生姜24g，半夏15g，炙甘草6g，党参9g。服3剂，腹满大减，续服3剂而愈。

十二字病理分析：

里虚：脉弱、舌淡苔白、纳差、神疲乏力

气实：腹胀满、按之不坚、时轻时重、食后及下午加重、暖气



小青龙汤

组成

麻黄去节 芍药 细辛 干姜 甘草炙 桂枝去皮各三两 五味子半升 半夏半升洗

比例

麻黄3桂枝3干姜3生白芍3炙甘草3细辛3姜半夏4五味子3

病理

表实

里虚

里寒

水实

病理症状

表实

发热恶寒，无汗

里虚

胃气不足，纳呆、干呕、乏力。

里寒

痰涕清稀

水实

咳喘、痰涎清稀量多、流清涕、舌苔白滑。

易混淆方

小青龙加石膏汤

厚朴麻黄汤

射干麻黄汤

麻杏石甘汤

大青龙汤

方剂	核心区别
小青龙汤	表寒里饮，恶寒发热、无汗、咳喘痰稀、不渴、心下水气。
小青龙加石膏汤	寒饮兼热，烦躁、口渴、喘甚。
厚朴麻黄汤	咳而脉浮胸满，喘满胸满更重。
射干麻黄汤	喉中痰鸣，喉中水鸡声、咽喉不利。
麻杏石甘汤	肺热喘，汗出而喘、无大热、痰黄热象。
大青龙汤	表实里热，无汗身疼、不汗出而烦躁。

辨证要点

伤寒表不解，心下水气是方证核心。

咳喘、痰涎清稀量多、鼻流清涕，舌苔白滑。

多不渴；若服后口微渴，可为寒饮去、津液复布。

可见干呕、下利、小便不利、少腹满、噎、喘等或然证。

相关原文

《伤寒论》40：伤寒表不解，心下水气，干呕，发热而咳，或渴，或利，或噎，或小便不利，少腹满，或喘者，小青龙汤主之。

《伤寒论》41：伤寒，心下水气，咳而微喘，发热不渴；服汤已渴者，此寒去欲解也，小青龙汤主之。

《金匮要略·痰饮咳嗽病》：病溢饮者，当发其汗，大青龙汤主之，小青龙汤亦主之。

《金匮要略·痰饮咳嗽病》：咳逆倚息不得卧，小青龙汤主之。

《金匮要略·妇人杂病》：妇人吐涎沫，医反下之，心下即痞；当先治其吐涎沫，小青龙汤主之；涎沫止，乃治痞，泻心汤主之。

医案

（矢数道明《汉方临床治验精粹》）：小儿哮喘，平素易感冒，感冒时咽红、扁桃体肿大，咳嗽，咯大量湿性稀薄痰，喷嚏、鼻涕多，食欲尚可。予小青龙汤提取物，服药3个月后体力精神转佳，感冒减少，哮喘发作消失。

十二字病理分析：

表实：易感冒、鼻喷嚏。

里寒：痰涕清稀湿性，属寒饮。

水实：大量稀薄痰、鼻涕多为水饮上犯。

气逆：哮喘、咳嗽。



茯苓甘草汤

组成

茯苓二两 桂枝二两去皮 甘草一两炙 生姜三两切

比例

炙甘草1 桂枝2 生姜3 茯苓2

病理

表虚

里虚

水实

病理症状

表虚

表虚汗出、表未解兼里有停饮。

里虚

胃中停饮、呕逆、胃口呆、纳差；胃气虚弱则水饮不化。

水实

胃中停水、心下悸、小便不利，水饮停于心下，重则水气上逆，轻则短气、心下动悸。

易混淆方

五苓散

苓桂术甘汤

苓桂枣甘汤

桂枝甘草汤

茯苓饮

真武汤

方剂	核心区别
茯苓甘草汤	胃中停水，心下悸、四肢厥、口不渴、小便不利，水证与表虚并重。
五苓散	水实气化不利，汗出而渴、小便不利、水入则吐，渴与尿不利更突出。
苓桂术甘汤	水饮上冲胸膈，心下逆满、气上冲胸、起则头眩，头眩明显。
苓桂枣甘汤	下焦水气上冲，脐下悸、欲作奔豚、气从少腹上冲，悸在脐下。
桂枝甘草汤	发汗过多心阳虚急，叉手自冒心、心下悸欲得按，无明显胃中停水。
茯苓饮	胃虚停饮兼气滞，胸中有停痰宿水、吐水、食后胀满，气滞食后胀更突出。
真武汤	阴性水饮，心下悸、头眩、身瞤动、形寒肢冷、脉沉弱，机能沉衰更重。

辨证要点

心下悸、胃口呆是本方最重要抓手。

第73条与五苓散鉴别：五苓散汗出而渴，本方不渴或渴不明显。

第356条抓厥而心下悸，宜先治水，四肢厥逆可由水饮气冲造成。

顽固失眠若有心下悸明显，可参考胡希恕经验加龙骨牡蛎。

相关原文

《伤寒论》第73条：伤寒汗出而渴者，五苓散主之；不渴者，茯苓甘草汤主之。注：《康平本》作“小渴者”，《宋本》作“不渴者”。

《伤寒论》第356条：伤寒厥而心下悸，宜先治水，当服茯苓甘草汤，却治其厥；不尔，水渍入胃，必作利也。

医案

（李冠杰，顽固失眠心下悸案）：女，约25、6岁，青年教师。长期失眠，曾多方求治，抽屉里装满治失眠的药而无效。诉因家庭与感情问题郁闷，问诊未见明显柴胡证，饮食、大小便基本正常。腹诊见心下跳动剧烈，胃口呆部动悸明显。辨为胃中停饮影响心神，予茯苓甘草汤加龙骨、牡蛎。服后当晚即迷糊入睡，次日睡眠更好，此后未再出现失眠。

十二字病理分析：

水实：心下跳动剧烈，胃中停饮为本。

气实：心下悸动影响心神，气冲不宁。

表虚：桂枝、生姜仍取表虚兼停饮之法。

里虚：胃功能不和，水饮不化。

半虚：情志郁闷但无明显柴胡证，精神症状由水饮扰神为主。



葛根芩连汤

组成

葛根半斤 甘草二两炙 黄芩三两 黄连三两

比例

葛根8 黄芩3 黄连3 炙甘草2

病理

表虚

里热

半热

病理症状

表虚

汗出、项背不舒、脉促。

里热

下利臭秽，口渴，尿赤

半热

胸膈烦热，喘而汗出，热势外越。

易混淆方

葛根汤

桂枝加葛根汤

白头翁汤

黄芩汤

半夏泻心汤

方剂	核心区别
葛根芩连汤	表未解兼里热下利，下利臭秽、肛门灼热、口苦口干、汗出喘。
葛根汤	表实项背强，无汗恶寒、项背强几几，无热利。
桂枝加葛根汤	表虚项背强，汗出恶风、项背强，无黄连清里热。
白头翁汤	厥阴热利，下利便脓血、里急后重。
黄芩汤	少阳热利腹痛，下利腹痛、口苦热象。
半夏泻心汤	痞利寒热错杂，心下痞、呕利肠鸣。

辨证要点

下利偏热：臭秽、黏滞、肛门灼热、口苦口干、苔黄腻。

兼汗出、喘、胸中烦热，或项背拘急、头身困重。

葛根量宜足，尤其项背强痛、头痛、下利并见时。

寒性下利、清谷不化、脉沉迟微弱者不宜。

相关原文

《伤寒论》34：太阳病，桂枝证，医反下之，利遂不止；脉促者，表未解也；喘而汗出者，葛根黄连黄芩汤主之。

医案

（矢数道明《临床应用汉方处方解说》）：男孩，4岁，突然高热至40℃，意识不清，泻下臭秽黏液便，并见促脉。予葛根黄连黄芩汤后，发热逐渐下降，下利减少；第3日热退。后因口渴、水入口即吐、烦躁、小便不利，转五苓散，呕吐止而愈。

十二字病理分析：

表虚：突发外感样高热，提示表未解。

半热：高热、意识不清、烦躁，为热势上扰。

里热：臭秽黏液便、下利为湿热下迫。

里虚：下利后胃气受损，后见水入口即吐。



柴胡加龙骨牡蛎汤

组成

柴胡四两 龙骨 黄芩 生姜 铅丹 人参 桂枝 茯苓各一两半 半夏二合半 大黄二两 牡蛎一两半 大枣六枚擘

比例

党参1.5 黄芩1.5 龙骨1.5 牡蛎1.5 桂枝1.5 姜半夏1.5 柴胡4 茯苓1.5 生姜1.5 大枣3 生大黄2

病理

半热

半虚

里虚

里实

水实

气实

病理症状

半热

胸满烦惊、口干苦、胸胁满痛，少阳半表半里热未解，热扰心神。

半虚

病程八九日又误下，少阳病被伤，见精神不安、食少纳呆、默默或呆滞。

里虚

小柴胡汤中保留人参、生姜、大枣，提示胃虚、纳呆、易呕、体质受损。

里实

方中用大黄，条文见谵语，可兼便秘、腹满、烦躁，属里热里实扰神。

水实

小便不利、一身尽重、不可转侧，停饮不化，废水阻滞肢体与神经系统。

气实

桂枝降冲，龙牡镇悸，适用于气上冲、心悸、胸腹动悸、惊恐不安。

易混淆方

小柴胡汤

大柴胡汤

柴胡桂枝干姜汤

桂枝甘草龙骨牡蛎汤

茯苓甘草汤加龙骨牡蛎

方剂	核心区别
柴胡加龙骨牡蛎汤	柴胡证兼神志水实，胸满烦惊、心悸、小便不利、身重、谵语。
小柴胡汤	少阳和解，胸胁苦满、心烦喜呕，无明显烦惊心悸。
大柴胡汤	里实更重，心下急、腹满拒按、便秘、呕不止。
柴胡桂枝干姜汤	虚寒津亏，渴而不呕、但头汗出、微结。
桂枝甘草龙骨牡蛎汤	误治后烦躁心悸，无柴胡证、心下悸欲按。
茯苓甘草汤加龙牡	胃中停饮悸眠差，无胸胁苦满、口苦。

辨证要点

柴胡证 + 烦惊心悸 + 小便不利是第一抓手。

胸满烦惊：胸胁满闷、心烦、惊恐、坐卧不安，精神症状突出。

小便不利、一身尽重、不可转侧：停饮水实，不只是情绪病。

谵语、便秘、腹满提示里热里实，大黄才有依据；便溏无实者慎用。

心下或脐上跳动明显、胸中忐忑，是龙骨牡蛎与桂枝茯苓类药的腹诊抓手。

本方可治失眠、焦虑、精神病样状态，但必须见半表半里证、水实或气冲证据。

若里实更重、便秘腹满口苦明显，可转大柴胡加龙骨牡蛎思路。

若单纯胃中停饮、无柴胡证，可考虑茯苓甘草汤加龙骨牡蛎，不必套本方。

现代临床铅丹多不用；原方记录保留，实际应用须慎重。

相关原文

《伤寒论》107：伤寒八九日，下之，胸满烦惊，小便不利，谵语，一身尽重，不可转侧者，柴胡加龙骨牡蛎汤主之。

《伤寒论》107方后注：本云柴胡汤，今加龙骨等（提示本方以柴胡汤为基础加味）。

《伤寒论·少阳篇》：少阳中风，两耳无所闻，目赤，胸中满而烦者，不可吐下，吐下则悸而惊（胡希恕用以说明少阳误下后烦惊机制）。

医案

（李冠杰讲稿，精神刺激后神经质）：临近县熊姓一家，老母亲去世后多人受精神刺激。四十多岁男子开小药店，整天觉得这里不舒服、那里不舒服，反复吃西药，体质渐弱，出现神经质状态。予柴胡加龙骨牡蛎汤，并随证合桂枝茯苓丸等清瘀血方，服后很快稳定，精神基本正常；后期出现小便不利，又改真武汤。

十二字病理分析：

半热：精神刺激后烦乱不安，属半表半里热扰心神。

半虚：久病、误治、反复服药后体质转弱，精神呆滞敏感。

水实：后期小便不利，提示停饮水实转重，故转真武汤方向。

血实：合桂枝茯苓丸，说明兼瘀血证，精神病样表现可夹血实。



桔梗汤

组成

桔梗一两 甘草二两

比例

桔梗2 甘草4

病理

半热

病理症状

半热

见咽痛、咽干、扁桃体红肿，忌发汗封喉。

易混淆方

甘草汤

苦酒汤

半夏散及汤

小柴胡加桔梗石膏

苇茎汤

方剂	核心区别
桔梗汤	甘草汤不差，咽痛肿重、排痰排脓、轻肺痛。
甘草汤	咽痛较轻，红肿不重、一味生甘草。
苦酒汤	咽痛重症，咽中痛、不能语言、声不出。
半夏散及汤	咽痛兼寒表，咽痛、恶寒无汗。
小柴胡加桔梗石膏	少阳咽痛，口苦、不欲食、胸胁证。
苇茎汤	肺痛热实，胸中甲错、咳吐脓痰、身有微热。

辨证要点

咽痛，扁桃体红肿为典型。

咽痛忌发汗，有表证亦慎麻桂，可葛根汤加桔梗。

排痰不利、咽中不爽，桔梗专证。

肺痛：胸满、浊唾腥臭、吐脓如米粥，脉数振寒。

桔梗用量不宜过大，加多易呕。

相关原文

《伤寒论》311：少阴病，二三日，咽痛者，可与甘草汤，不差，与桔梗汤。

《金匱要略·肺痿肺痛咳嗽上气病》：咳而胸满，振寒脉数，咽干不渴，时出浊唾腥臭，久久吐脓如米粥者，为肺痛，桔梗汤主之。

《神农本草经》：桔梗治胸胁痛如刀刺。

医案

（胡希恕，感冒咽痛少阳阳明合病）：女，35岁，感冒三天，咽痛、口干、恶心、不欲食，咳则右上胸疼，苔白，脉弦细稍数。辨少阳阳明合病，予小柴胡汤加石膏、桔梗，三剂咽痛愈。

十二字病理分析：

半热：咽痛、口干、脉弦细数，半表半里热。

半虚：恶心、不欲食，胃气虚。

里热：口干、脉稍数



越婢加朮汤

组成

麻黄六两石膏半斤生姜三两甘草二两白朮四两大枣十五枚

比例

麻黄6 生石膏8 生姜3 炙甘草2 白朮4 大枣15枚

病理

表实

里热

水实

病理症状

表实

主表不解、风水外郁、恶风或无汗、浮肿在肌表，出汗不必然排除本方。

里热

发热、汗出、口渴、口干、烦热、尿黄或皮肤热肿。

水实

一身面目黄肿、小便不利、身重、下肢水肿、腹水、关节肿。

易混淆方

越婢汤

甘草麻黄汤

大青龙汤

麻杏石甘汤

防己黄芪汤

麻黄连翘赤小豆汤

方剂	核心区别
越婢加朮汤	越婢汤证加水湿，身肿、小便不利、里热、表实、水肿或湿痹疼痛。
越婢汤	风水热肿，恶风、一身悉肿、续自汗出、无大热，小便不利或湿痹不如加朮方突出。
甘草麻黄汤	里水表实无汗，浮肿、无汗、里热不明显，药味简而偏发越水气。
大青龙汤	表实寒束兼里热烦躁，恶寒无汗、身疼痛、烦躁，发汗力更峻，误用易大汗亡阳。
麻杏石甘汤	肺热喘咳，汗出而喘、口渴、咳喘，不以一身面目水肿为主。
防己黄芪汤	表虚风水，汗出恶风、身重、脉浮、虚胖，偏表虚，不宜麻黄峻发。
麻黄连翘赤小豆汤	表实湿热发黄，身黄身痒、小便短赤、发热恶寒，黄疸湿热是主轴。

辨证要点

越婢汤证见小便不利或湿痹疼痛，是本方基本入口。

一身面目黄肿 + 小便不利 + 脉沉/浮滑。

表实、里热、水实同在：有麻黄证、石膏证、白朮水湿证，不可只按水肿病名套方。

肾炎水肿、肾炎腹水是常见场景，但仍以方证为核心。

相关原文

《金匱要略·水气病》：风水，恶风，一身悉肿，脉浮不渴，续自汗出，无大热，越婢汤主之。

《金匱要略·中风历节病》：《千金方》越婢加朮汤，治肉极热，则身体津脱，腠理开，汗大泄，厉风气，下焦脚弱。

《金匱要略·水气病》：里水者，一身面目黄肿，其脉沉，小便不利，故令病水。假令小便自利，此亡津液，故令渴也，越婢加朮汤主之。

《金匱要略·水气病》：里水，越婢加朮汤主之，甘草麻黄汤亦主之。

医案

医案1（胡希恕讲稿，肾炎腹水住院会诊）：住院患者，肾脏炎并发腹水，外边浮肿相当厉害。胡老会诊后开越婢加朮汤，服后腹水、浮肿好转。胡老强调此类肾炎腹水用本方经验很多，但肝硬化腹水套用则不效，说明必须合方证。

十二字病理分析：

表实：水走肌表，外边浮肿相当厉害，须用麻黄发越水气。

里热：越婢汤石膏证，肾炎水肿常兼郁热，不是纯寒水。

水实：肾炎腹水、全身浮肿，里水与外水并见。



厚朴麻黄汤

组成

厚朴五两 麻黄四两 石膏如鸡子大 杏仁半升 半夏半升 干姜二两 细辛二两 小麦一升 五味子半升

比例

厚朴5 麻黄4 生石膏16 细辛2 干姜2 杏仁4 姜半夏4 五味子3

病理

表实

里热

水实

气实

病理症状

表实

发热、恶寒、无汗、头身疼痛、咳喘

里热

烦躁、口渴、黄痰、脉洪大

水实

心下有水气、痰饮内停。

气实

咳逆上气、胸满短气、喘满。

易混淆方

小青龙汤

小青龙加石膏汤

射干麻黄汤

麻杏石甘汤

泽漆汤

大青龙汤

方剂	核心区别
厚朴麻黄汤	咳而脉浮，外邪内饮、喘满胸满、咳逆上气。
小青龙汤	表寒里饮，恶寒发热、咳喘痰稀、不渴。
小青龙加石膏汤	寒饮兼热，喘烦、心下有 水、口渴或烦躁。
射干麻黄汤	喉中痰鸣，喉中水鸡声。
麻杏石甘汤	肺热喘，汗出而喘、无大热。
泽漆汤	里饮为主，咳而脉沉。
大青龙汤	表实里热，无汗身疼烦躁。

辨证要点

咳而脉浮、胸满喘满。

可兼里热：烦躁、口渴、黄痰、脉洪大，石膏为主药。

近似小青龙加石膏证而喘满更重、不需大发汗者。

脉沉主里饮无表者，宜泽漆汤，非本方。

大量小麦养正有余、逐水不足，溢饮非本方所主。

相关原文

《金匮要略·肺痿肺痛咳嗽上气病》：咳而脉浮者，厚朴麻黄汤主之。

《金匮要略·肺痿肺痛咳嗽上气病》：咳而脉浮者，厚朴麻黄汤主之；脉沉者，泽漆汤主之。

医案

（李冠杰讲稿，多年咳喘遇寒即发）：男，多年喘咳，稍着凉即剧咳，脉浮、洪大，明显有热象。予厚朴麻黄汤，咳喘明显减轻，仍吐黄痰（患者曾外用活血药后体质偏热）。初方石膏已不少，再增石膏后上午服药下午便稀；改予厚朴麻黄汤减石膏，患者觉胸满、肺悬、憋气、气短大减，身体轻松。提示方证已对，石膏随里热进退。

十二字病理分析：

表实：脉浮、遇寒即发，表邪引动旧疾。

里热：脉洪大、黄痰、烦热，饮郁化热。

水实：多年痰喘，内饮伏肺。

气实：胸满憋短、喘咳，厚朴杏仁降逆。



麻黄加术汤

组成

麻黄三两去节 桂枝二两去皮 甘草一两炙 杏仁七十个去皮尖 白术四两

比例

麻黄3 桂枝2 炙甘草1 杏仁3 白术4

病理

表实

水实

病理症状

表实

恶寒无汗、身体烦疼、脉浮紧

水实

小便不利，身重，苔白腻

易混淆方

麻黄汤

麻黄加术汤

麻杏苡甘汤

防己黄芪汤

大青龙汤

方剂	核心区别
麻黄汤	纯表实寒证，恶寒发热、无汗而喘、身痛脉浮紧，无湿象，以喘为特征。
麻黄加术汤	表实兼寒湿，身烦疼、身重酸困、苔白腻，痛且重着，无热象。
麻杏苡甘汤	风湿有化热，一身尽疼、发热日晡所剧，无寒象，去桂枝加苡仁。
防己黄芪汤	表虚湿重，汗出恶风、身重脉浮，有汗，非表实。
大青龙汤	表实兼里热，不汗出而烦躁、身疼痛，有内热烦躁，非单纯寒湿。

辨证要点

第一抓手：身体烦疼 + 恶寒无汗 + 身重酸困

疼痛特点是「烦疼」：疼得厉害、酸重难受、转侧不利，不是单纯的麻黄汤身痛。

必须无汗：有汗身痛是桂枝汤或其他方，不是麻黄加术汤。

湿象判断：身重、苔白腻、脉濡缓或浮紧，都是湿邪的依据。

发病诱因：多有淋雨受凉、久居湿地、汗出当风等病史。

相关原文

《金匮要略·痉湿喝病脉证治第二》：湿家身烦疼，可与麻黄加术汤发其汗为宜，慎不可以火攻之。

《金匮要略·痉湿喝病脉证治第二》：湿家，其人但头汗出，背强，欲得被覆向火，若下之早则哕，或胸满，小便不利，舌上如胎者，以丹田有热，胸上有寒，渴欲得饮而不能饮，则口燥烦也。

《金匮要略·痉湿喝病脉证治第二》：风湿相搏，一身尽疼痛，法当汗出而解，值天阴雨不止，医云此可发汗，汗之病不愈者，何也？盖发其汗，汗大出者，但风气去，湿气在，是故不愈也。若治风湿者，发其汗，但微微似欲出汗者，风湿俱去也。

医案

医案1（冯世纶传真，发热恶寒身困案）：老年男性，既往丝虫病病史，每年8月左右发热恶寒，今年发作服西药无效。刻诊：发热恶寒，无汗，身酸困乏力，无口干口苦，纳可，二便尚调，舌淡苔薄白，脉细。六经辨证太阳太阴合病，麻黄加术汤证。处方：麻黄18g，桂枝12g，杏仁10g，炙甘草6g，苍术12g。3剂。服药汗出而愈。

十二字病理分析：

表实：发热恶寒、无汗、脉浮细，寒湿束表，营卫郁闭。

水实：身酸困乏力、苔薄白，湿邪困阻肌表。



小青龙加石膏汤

组成

麻黄 芍药 细辛 干姜 炙甘草 桂枝各三两 五味子 半夏各半升 石膏二两

比例

麻黄3 生白芍3 细辛3 干姜3 炙甘草3 桂枝3 五味子3 姜半夏4 石膏2

病理

表实

里寒

里热

水实

半虚

气实

病理症状

表实

脉浮、恶寒、发热、无汗，麻黄桂枝发汗解表。

里寒

心下有水气、痰白清稀、背恶寒，干姜细辛温化寒饮。

里热

烦躁、黄痰、口干、苔黄、舌尖红，加石膏清热除烦。

水实

咳而上气、痰多、喘、倚息不得卧，心下有水饮。

半虚

胃气不足，饮水后胃脘不适，甘草芍药安中。

气实

肺胀、胸满、咳逆倚息，肺气壅实不降。

易混淆方

方剂	核心区别
1. 小青龙汤	咳喘痰稀、不渴、无热象，纯寒饮无里热。
2. 小青龙加石膏汤	小青龙汤证 + 烦躁、口渴、黄痰，寒饮兼里热。
3. 大青龙汤	表实重、烦躁重、麻黄六两，无寒饮，重心在发汗清热。
4. 厚朴麻黄汤	小青龙加石膏变剂，加厚朴杏仁去桂枝芍药，偏治喘满、胸满、短气。
5. 射干麻黄汤	咳而上气、喉中水鸡声，咽中痰鸣为主，用射干紫菀款冬花。
6. 越婢加半夏汤	肺胀、咳而上气、喘、目如脱状，热饮为主，偏阳明。

辨证要点

小青龙汤证 + 烦躁 = 小青龙加石膏汤证，是核心公式。

抓手一：咳喘、痰多清稀或黄白相兼，心下有水气。

抓手二：烦躁、口干、苔黄、舌尖红，寒饮化热。

抓手三：脉浮、恶寒、无汗，表不解。

抓手四：背恶寒如掌大，心下有留饮。

痰全黄稠、纯热无寒者，不可用本方，当考虑越婢加半夏汤或麻杏石甘汤。

与厚朴麻黄汤鉴别：胸满、短气明显者偏厚朴麻黄汤；咳喘痰多兼烦躁者偏本方。

里热轻者减石膏量，热退后可去石膏，纯小青龙汤善后。

相关原文

《金匮要略·肺痿肺痛咳嗽上气病》14：肺胀，咳而上气，烦躁而喘，脉浮者，心下水，小青龙加石膏汤主之。

《金匮要略·痰饮咳嗽病》（参照）：病溢饮者，当发其汗，大青龙汤主之，小青龙汤亦主之。

《伤寒论》40（参照）：伤寒表不解，心下水气，干呕，发热而咳……小青龙汤主之。

医案

（胡希恕，小青龙加石膏汤证）：李某，男，63岁。咳嗽吐黄白痰4个月，心烦胸满，背恶寒，口干思饮，饮水后胃脘不适，苔黄腻，舌尖红，脉弦滑细。予小青龙加石膏汤：麻黄三钱，桂枝三钱，细辛二钱，干姜二钱，白芍三钱，炙甘草三钱，五味子三钱，半夏五钱，生石膏一两半。服三剂，心烦胸满减，黄痰减少，口干减。增细辛干姜为三钱，减石膏为一两，继服六剂，背恶寒已，已不见黄痰，去石膏，继服12剂症已。

十二字病理分析：

表实：恶寒（背恶寒）、脉浮弦，表邪未解。

里寒：背恶寒如掌大、咳痰白、饮水后胃脘不适，心下有留饮。

里热：心烦、黄痰、口干、苔黄腻、舌尖红，寒饮郁而化热。

水实：咳嗽吐痰量多、脉弦滑，心下有水气。

半虚：饮水后胃脘不适，胃气不足。

气实：胸满、心烦，肺气壅实。



麻杏苡甘汤

组成

麻黄半两 甘草一两炙 薏苡仁半两 杏仁十枚去皮尖炒

比例

麻黄4 薏苡仁5 杏仁2 炙甘草2

病理

表实

里热

水实

病理症状

表实

一身尽疼、发热，急性发作时多见恶寒、脉浮、无明显自汗。

里热

发热、日晡所剧。

水实

湿饮停着肌肉关节，身重、关节痛、筋急拘挛、肿胀或小便不利。

易混淆方

麻黄加术汤

甘草附子汤

桂枝芍药知母汤

越婢加术汤

方剂	核心区别
麻杏苡甘汤	湿热痹偏表实， 一身尽疼、发热日晡所剧、身重关节痛。
麻黄加术汤	寒湿在表， 湿家身烦疼、偏寒、恶寒无汗 ，用白术偏温燥湿。
甘草附子汤	虚寒湿痹， 骨节疼烦、掣痛不得屈伸、汗出短气、小便不利。
桂枝芍药知母汤	历节夹水热， 脚肿如脱、头眩短气、温温欲吐 ，病程多较深。
越婢加术汤	风水热肿， 身肿、续自汗出、口渴或里热明显。

辨证要点

一身尽疼，发热，日晡所剧是条文核心。

主治湿热痹痛：周身关节痛、身重或肿、筋急拘挛。

必须抓住表实 + 里热 + 水实，三者缺一则要慎重。

偏热湿者用薏苡仁；偏寒湿、头痛恶寒明显者，多与麻黄加术汤鉴别。

相关原文

《金匮要略·痉湿喝病》：病者**一身尽疼，发热，日晡所剧者**，名风湿。此病伤于汗出当风，或久伤取冷所致也。可与**麻黄杏仁薏苡甘草汤**。

医案

（李冠杰临床）：男，30多岁，体壮，为修车工。腰痛明显，往车下修车时疼痛很厉害；辨其有水证、里热，且不怎么出汗，属表实湿热痹痛。予麻杏苡甘汤，服一次后效果非常好。

十二字病理分析：

表实：**不怎么出汗、体壮、急性腰痛**，表闭湿郁。

里热：李冠杰明言有里热，提示湿郁偏热，不属纯寒湿。

水实：**腰痛、活动受限、湿滞筋骨关节**，水湿停着肌肉关节。

气实：疼痛局部拘急，气血运行不畅（次要）。



麻黄连翘赤小豆汤

组成

麻黄二两 连翘二两 杏仁四十枚 赤小豆一升 大枣十二枚 生梓白皮一升 生姜二两 甘草二两

比例

麻黄2 连翘2 生姜2 炙甘草2 赤小豆12 桑白皮4 杏仁1 大枣5

病理

表实

里热

水实

病理症状

表实

表邪未解、无汗或微恶风寒。

里热

瘀热在里、湿热发黄或皮肤红痒。

水实

见小便短赤、水肿、苔腻、身黄或身痒。

易混淆方

茵陈蒿汤

栀子柏皮汤

栀子大黄汤

桂枝加黄芪汤

越婢加术汤

方剂	核心区别
麻黄连翘赤小豆汤	表实湿热发黄， 发热恶寒、无汗、身黄或身痒、小便短赤。
茵陈蒿汤	阳明湿热黄疸， 身黄如橘子色、小便不利、腹微满 ，表证不重。
栀子柏皮汤	黄疸热重实轻， 身黄发热、心烦、无明显表实。
栀子大黄汤	湿热黄疸兼里实， 心中懊憹、腹满、大便不通或酒疸。
桂枝加黄芪汤	黄汗表虚， 汗出恶风、黄汗、脉浮缓 ，不是无汗表实。
越婢加术汤	风水热肿， 身肿、续自汗出、口渴、尿少 ，黄疸身痒不是主轴。

辨证要点

伤寒瘀热在里，身必黄是条文主轴。

抓手一：发热恶寒、无汗、脉浮，表邪未解。

抓手二：身黄目黄、尿短赤、舌红苔黄腻，湿热在里。

抓手三：皮肤红疹瘙痒、水肿、小便不利、苔腻，湿热水毒郁于肌表。

里寒、便溏、畏寒重、脉沉弱者慎用，必要时合温里方。

相关原文

《伤寒论》262：伤寒，**瘀热在里，身必黄**，麻黄连翘赤小豆汤主之。

医案

（刘渡舟，周身瘙痒）：高某，男，20岁。周身皮疹，色红成片，奇痒难忍，搔之画缕成痕而高出皮面。多用疏风清热利湿药不效。微恶风寒，小便短赤不利，舌苔白而略腻，脉浮弦。辨为风湿客表、阳气拂郁而有郁热成疸之机。予麻黄、连翘、杏仁、桑白皮、赤小豆、生姜、炙甘草、大枣，2剂微汗出而瘥。十二字病理分析：
表实：**微恶风寒、脉浮弦、得微汗而瘥**，表邪未解。
里热：**皮疹色红、奇痒、小便短赤**，郁热在里外蒸肌表。
水实：**苔白略腻、小便不利、皮疹高起**，湿热水毒郁于肌肤。



大青龙汤

组成

麻黄六两去节桂枝二两去皮甘草二两炙杏仁四十枚去皮尖生姜三两切大枣十枚擘石膏鸡子大碎

比例

麻黄6 桂枝2 炙甘草2 杏仁2 生姜3 大枣4 石膏16

病理

表实

里热

水实

病理症状

表实

表实严重，恶寒身疼、脉浮紧、不汗出；应汗而不得汗。

里热

里热郁蒸，烦躁、口渴、舌红苔黄；热不得外越故更烦。

水实

体表停饮，里热迫津外达而表闭，见身重、乍有轻时、溢饮浮肿。

易混淆方

麻黄汤

葛根汤

麻杏石甘汤

小青龙汤

越婢汤

方剂	核心区别
大青龙汤	表实里热体表停饮，不汗出而烦躁、恶寒身疼、脉浮紧。
麻黄汤	表实无汗，恶寒身疼痛，无明显烦躁里热。
葛根汤	表实项背强，项背强几几、无汗恶风，烦躁不重。
麻杏石甘汤	热喘为主，汗出而喘、无大热，表实身痛较轻。
小青龙汤	表寒里饮，咳喘痰稀、不渴或寒饮。
越婢汤	风水身肿汗出，续自汗出、身肿、里热。

辨证要点

脉浮紧、发热恶寒、身疼痛、不汗出而烦躁是核心方证。

脉浮缓、身不疼但重、乍有轻时、无少阴证，主体表停饮。

若脉微弱、汗出恶风者，不可服——真太阳中风禁用。

取微似汗，一服得汗即停，不可过汗。

相关原文

《伤寒论》38：太阳中风，脉浮紧，发热恶寒，身疼痛，不汗出而烦躁者，大青龙汤主之。若脉微弱，汗出恶风者，不可服之，服之则厥逆，筋惕肉瞤。

《伤寒论》39：伤寒，脉浮缓，身不疼，但重，乍有轻时，无少阴证者，大青龙汤发之。

方后注：温服一升，取微似汗；汗出多者，温粉扑之；一服汗者，停后服；若复服汗多，亡阳遂虚，恶风烦躁不得眠。

《金匱要略·痰饮咳嗽病》：病溢饮者，当发其汗，大青龙汤主之，小青龙汤亦主之。

医案

（黎崇裕医案，咽痛高烧）：女，5岁。食油炸饮食后起病，见咽痛、口干、精神不佳、恶寒无汗、鼻塞流清涕、高热39℃，欲大便而不得，舌脉未详。辨为外寒束表、里有郁热，予大青龙汤：生麻黄12g、桂枝6g、炙甘草6g、杏仁6g、生姜3片、红枣6枚、生石膏30g，1剂。嘱先服一碗，盖被取微汗，汗出烧退即停后服；若2小时仍不汗，再服余药。次日反馈：服药半小时后开始出汗，热退且夜间未反复；余有腹痛、未大便、痰声辘辘、轻咳鼻塞，后续另方调理。

十二字病理分析：

表实：恶寒无汗、鼻塞流清涕、高热初起，外寒闭表，卫表不得开。

里热：咽痛、口干、高热、欲便不得，里热郁而不得外越。

水实：鼻塞流涕、痰声辘辘，肺卫水气未利。

气逆：后续轻咳、痰声，肺气宣降尚未完全恢复。



甘草附子汤

组成

甘草二两炙 附子二枚炮去皮破 白术二两 桂枝四两去皮

比例

桂枝4 炙甘草2 苍术2 附子2

病理

表虚

水实

阴证

病理症状

表虚

风湿在表，汗出恶风，关节疼痛。

水实

湿饮停着关节，身微肿、小便不利。

阴证

机能沉衰，恶风不欲去衣，脉多沉细弱。

易混淆方

桂枝附子汤

桂枝芍药知母汤

乌头汤

越婢加术汤

方剂	核心区别
甘草附子汤	虚寒湿痹， 骨节疼烦、掣痛不得屈伸、汗出短气、小便不利。
桂枝附子汤	风湿表虚， 身体疼烦、不能自转侧、脉浮虚涩。
桂枝芍药知母汤	历节夹水热， 脚肿如脱、头眩短气、温温欲吐。
乌头汤	寒痹痛最剧， 疼痛不可屈伸、寒象重。
越婢加术汤	风水热肿， 身肿、续自汗出、口渴或里热。

辨证要点

骨节疼烦，掣痛不得屈伸，近之则痛剧是核心。

汗出短气、小便不利、恶风不欲去衣，提示虚寒湿痹。

可见身微肿或关节肿胀，水湿偏着关节。

恶寒重、脉沉细弱者更合附子证。

红肿热痛、口渴烦躁、脉滑数实热者慎用，应与越婢加术汤等鉴别。

相关原文

《伤寒论》175：风湿相搏，**骨节疼烦，掣痛不得屈伸，近之则痛剧，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣**，或身微肿者，甘草附子汤主之。

《金匮要略·痉湿喝病》：风湿相搏，**骨节疼烦，掣痛不得屈伸，近之则痛剧，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣**，或身微肿者，甘草附子汤主之。

医案

（大塚敬节医案）：女，17岁，扁桃体炎后连续高热，四肢疼痛，继而膝、踝关节肿痛，不能站立，呼吸迫促，尿量减少，虽汗出而热不退，兼恶寒，脉浮大，舌湿无苔。连续服甘草附子汤约2个月而痊愈。

十二字病理分析：

阴证：恶寒、尿少、久病不解，机能沉衰。

表虚：汗出而热不退，风湿在表。

里寒：恶寒、舌湿，为虚寒背景。

水实：**膝踝肿痛、尿量减少**，湿饮停着关节。

气逆：呼吸迫促、短气，为气机上逆。



麦门冬汤

组成

麦门冬七升 半夏一升 人参二两 甘草二两 粳米三合 大枣十二枚

比例

麦冬60 炙甘草2 党参2 粳米4 姜半夏8 大枣5

病理

里热

水虚

气实

病理症状

里热

火逆上气，虚热上扰，咽干口燥，咽喉不利

水虚

津液虚，咽喉缺津少液，口燥咽干，黏痰不爽

气实

咳逆上气，气逆不降，咽中痰黏缠绕，咳吐费力

易混淆方

炙甘草汤

半夏厚朴汤

竹叶石膏汤

小青龙汤

方剂	核心区别
麦门冬汤	胃肺津虚上逆，咽喉不利、干咳少痰、逆气上冲、口燥咽干。
炙甘草汤	阴血阳气俱虚，脉结代、心动悸、虚劳。
半夏厚朴汤	痰气郁结，咽中如有炙脔、胸闷情志郁。
竹叶石膏汤	病后余热气津伤，虚烦、呕逆、口渴、气逆。
小青龙汤	寒饮咳喘，痰稀白沫、恶寒无汗、不渴。

辨证要点

咳逆、咽干口燥、咽喉不利者

咳逆上气，咳嗽较深

黏痰不爽，咳吐费力

津液虚兼虚热

非普通湿痰咳嗽，须见干燥少津

相关原文

《金匱要略·肺痿肺痛咳嗽上气病》：大逆上气，咽喉不利，止逆下气者，麦门冬汤主之。

胡希恕据《医宗金鉴》校注：此处“大逆上气”宜作“火逆上气”。

医案

冯世纶医案：阎某，女，44岁，2014年9月4日初诊。口中“喷火感”一月余，口干、咽干，食欲可但不消化，无腹胀，前几日齿衄，小腿肚酸胀，汗可、有时多，晨起阵汗出，不恶风，劳累后尿频急，大便黏，2~3日一行，舌淡苔薄白，脉细。

辨为阳明太阴合病，方证取麦门冬汤加生石膏生姜。处方：麦冬30克，清半夏15克，党参10克，炙甘草6克，生石膏45克，大米一撮，姜3片，枣4枚，6剂。二诊口热减、口黏减、口中觉润、食欲好转。

后又调理半月余，服后再无不适。

来源：北京中医药大学转载《中国中医药报》朱梦龙《冯世纶麦门冬汤治“口中喷火感”案》。



茯苓饮

组成

茯苓三两 人参三两 白术三两 枳实二两 橘皮二两半 生姜四两

比例

枳实2 陈皮3 茯苓3 苍术3 党参3 生姜4

病理

里虚

水实

气实

病理症状

里虚

心胸间虚、不能食、
纳差、胃气弱，脉弱

水实

吐水、胃内振水音、
苔厚腻、头晕心悸

气实

气满、胸满、腹胀、
心下痞，暖气

易混淆方

旋覆代赭汤

半夏泻心汤

茯苓甘草汤

厚朴生姜半夏甘草人参汤

方剂	核心区别
茯苓饮	胃虚停饮兼气滞，胸中有停痰宿水、吐水、心胸中有气、食后胀满。
旋覆代赭汤	胃虚气逆，噎气不除、心下痞硬。
半夏泻心汤	寒热错杂痞，心下痞、呕利肠鸣。
茯苓甘草汤	水饮悸动，心下悸、四肢厥、胃中停水。
厚朴生姜半夏甘草人参汤	虚胀，腹胀满、按之坚、食后加重。

辨证要点

胸满、腹胀、心下痞，兼食欲不振

胃中停饮：吐水、痰水、胃内振水音或苔厚腻

暖气后反觉舒服，偏橘皮、枳实所主的气满

呕吐水饮重者可合小半夏汤，胀满闭塞重者可加重橘皮、枳实

相关原文

《金匮要略·痰饮咳嗽病》附方：《外台》茯苓饮，治心胸中有停痰宿水，自吐出水后，心胸间虚，气满不能食。消痰气，令能食。

医案

黄煌医案：李某，女，39岁，160cm、48kg。产后两年出现抑郁、胸中憋闷、心悸、烦躁不安、食欲差；近来上腹胀痛，食后明显，偶有反酸，大便偏溏，常头晕，入睡困难。体瘦，面黄有斑，胃内振水音，脐周动悸，舌苔厚腻，脉弱，血压偏低。处方以茯苓饮加减，服后腹胀减轻，睡眠改善。

十二字病理分析：

里虚：产后、体瘦、面黄、食欲差、脉弱、血压偏低，提示胃气不足。

水实：胃内振水音、舌苔厚腻、头晕，为胃中停饮。

气实：胸中憋闷、上腹胀痛、食后更甚、暖气反酸，为气机壅滞上逆。



麻黄附子细辛汤

组成

麻黄二两 细辛二两 附子一枚炮

比例

麻黄2 细辛2 附子1

病理

表实

里寒

水实

阴证

病理症状

表实

反发热、无汗或汗少。

里寒

恶寒肢冷；里虚寒为本。

水实

脉沉里有寒饮。

阴证

机能沉衰；素虚或老年多见，精神不振、肢冷、但欲寐。

易混淆方

麻黄附子甘草汤

麻黄汤

桂枝加附子汤

小青龙汤

方剂	核心区别
麻黄附子细辛汤	少阴表实兼寒饮，恶寒无汗、脉沉、精神沉、寒饮头痛。
麻黄附子甘草汤	少阴表证较缓，少阴二三日、无里证、微发汗。
麻黄汤	太阳表实，脉浮紧、身疼痛、精神不沉。
桂枝加附子汤	表虚阳虚，汗出恶风、汗漏不止。
小青龙汤	表寒里饮咳喘，咳喘痰稀、心下有水气。

辨证要点

第一抓手：少阴始得、反发热、脉沉。

反字贯发热与脉沉：少阴本不发热、脉不当沉，皆属「反」。

隐含：脉微细、但欲寐、恶寒、无汗、身痛

脉象以沉细为典型，沉紧、沉微、沉迟亦可。

表阴证里有寒饮，须解表与逐饮同治，不可单汗。

相关原文

《伤寒论》301：少阴病，始得之，反发热，脉沉者，麻黄附子细辛汤主之。

《金匱》：脉得诸沉，当责有水。水在里者，热反外郁。

太阳篇：发热恶寒发于阳，无热恶寒发于阴。故少阴以不发热为常。

接续（92条义）：服麻黄附子细辛汤若不差，身体疼痛、脉仍沉者，不可再发汗，宜温里（四逆汤）。

医案

（岳美中，秋感风寒）：中年男子，秋天遇风寒后全身发冷，恶寒明显，他医处方疗效不佳。岳美中诊其脉沉细，辨为少阴表证，予麻黄附子细辛汤，半剂即效。

十二字病理分析：

阴证：脉沉细、全身发冷，机能不足，邪入少阴。

表实：外感风寒后恶寒明显，表邪未解。

里寒：全身冷、恶寒重，附子温阳散寒。

水实：脉沉。



射干麻黄汤

组成

射干十三枚 麻黄四两 生姜四两 细辛三两 紫菀三两 款冬花三两 五味子半升 大枣七枚 半夏大者八枚洗

比例

射干3 麻黄4 生姜4 细辛3 紫菀3 款冬花3 五味子8 大枣3 半夏4

病理

表实

里寒

里虚

水实

气实

病理症状

表实

发热、恶寒、无汗、身疼痛、咳喘

里寒

痰白清稀或白黏。

里虚

久咳、反复发作可兼肺胃正气不足。

水实

喉中水鸡声、喉间痰鸣、痰饮壅阻气道。

气实

咳逆上气、喘急、胸闷憋气。

易混淆方

小青龙汤

厚朴麻黄汤

小青龙加石膏汤

麻杏石甘汤

葶苈大枣泻肺汤

方剂	核心区别
射干麻黄汤	外邪内饮而喉中水鸡声、咽中痰鸣、咳而上气最突出。
小青龙汤	表寒里饮，恶寒发热、无汗、咳喘痰稀、不渴、心下水气，咽喉痰鸣不如本方专。
厚朴麻黄汤	咳而脉浮，胸满喘满、咳逆上气更重，可兼里热。
小青龙加石膏汤	寒饮兼热，喘烦、口渴、烦躁或痰热。
麻杏石甘汤	肺热喘，汗出而喘、无大热、口渴或痰黄热象，非寒饮痰鸣主轴。
葶苈大枣泻肺汤	肺实水壅，喘不得卧、面目浮肿、痰涎壅盛，重在泻肺逐水。

辨证要点

喉中水鸡声是第一抓手：喉间痰鸣、湿鸣，呼吸或说话时痰声明显。

咽喉不利、痰结咽中明显，是本方区别小青龙汤的重要点。

若咽喉利落、无痰鸣，单纯咳喘不宜套用本方。

若热象明显，可参考胡希恕经验加石膏；纯肺热喘则偏麻杏石甘汤。

相关原文

《金匱要略·肺痿肺痛咳嗽上气病》：咳而上气，喉中水鸡声，射干麻黄汤主之。

医案

(临床医案，慢性支气管炎)：患者咳嗽十余年，近二月加重。胸闷憋气，咳喘气急、咳白黏痰、喉间痰鸣音较重，吸冷气、油烟、进食呛咳后加重，咳甚头胀头痛，胃口、睡眠尚可，二便可，舌淡红，苔薄，脉沉。辨为寒饮伏肺、肺气不降，予射干麻黄汤原方。服1剂后咳喘明显减轻，3剂服完咳喘、闷憋、痰鸣、头痛诸症悉除。

十二字病理分析：

表实：头胀头痛。

里寒：白黏痰、遇冷加重，为寒饮背景。

水实：喉间痰鸣音较重、咳白黏痰，痰饮壅阻气道。

气实：胸闷憋气、咳喘气急，肺气上逆不降。



五苓散

组成

猪苓十八铢去皮 泽泻一两六铢 白术十八铢 茯苓十八铢 桂枝半两去皮

比例

桂枝2 猪苓3 苍术3 茯苓3 泽泻5

病理

表虚

水实

气实

病理症状

表虚

汗出而渴、脉浮、微热。

水实

小便不利、废水不出、新水不吸收，里停水致消渴；

气实

气上冲、头晕、心悸、水逆

易混淆方

猪苓汤

苓桂术甘汤

茯苓泽泻汤

白虎加人参汤

小青龙汤

方剂	核心区别
五苓散	水实兼表/气化不利，小便不利、渴欲饮水、水入则吐、头眩心悸。
猪苓汤	水热伤阴，小便不利、尿痛尿血、心烦不得眠，无桂枝气冲。
苓桂术甘汤	水饮上冲，心下逆满、起则头眩、脉沉紧，无渴欲饮水重。
茯苓泽泻汤	胃反吐后渴，吐而渴欲饮水。
白虎加人参汤	津虚大渴，口干舌燥、欲饮数升，非小便不利。
小青龙汤	寒饮咳喘，咳喘痰稀、表寒。

辨证要点

小便不利 + 渴欲饮水（消渴、越喝越渴）是第一抓手。

水入则吐为水逆，为本方典型证。

与茯苓甘草汤：后者小渴或不渴、心下悸、汗出（73条）。

与猪苓汤：后者里热尿痛、无汗、无气上冲；本证可见汗出。

里有停水不可单纯发汗；汗后仍脉浮小便不利，宜本方。

水逆、胃停饮重者，散剂优于汤剂。

相关原文

《伤寒论》71：太阳病发汗后，大汗出，胃中干，烦躁不得眠，欲得饮水者，少少与饮之，令胃气和则愈。若脉浮，小便不利，微热消渴者，五苓散主之。

《伤寒论》72：发汗已，脉浮数，烦渴者，五苓散主之。

《伤寒论》73：伤寒汗出而渴者，五苓散主之；小渴者，茯苓甘草汤主之。

《伤寒论》74：中风发热六七日不解而烦，有表里证，渴欲饮水，水入则吐者，五苓散主之，名曰水逆。

《伤寒论》156：心下痞，与泻心汤，痞不解，其人渴而口燥者，小便不利者，五苓散主之。

《伤寒论》244：渴者，宜五苓散。

《伤寒论》386：霍乱，身疼痛，热多欲饮水者，五苓散主之；寒多不用水者，理中丸主之。

《金匱·痰饮》：假令瘦人，脐下有悸，吐涎沫而癫眩，此水也，五苓散主之。

《金匱·消渴小便不利淋病》：脉浮，小便不利，微热消渴者，宜利小便、发汗，五苓散主之。

《金匱·消渴小便不利淋病》：渴欲饮水，水入则吐者，名曰水逆，五苓散主之。

医案

（李冠杰讲稿，过饮伤胃）：夏日口渴，一次性猛灌约一升凉水，本以为可解渴，结果胃里难受、欲吐。印证第71条：发汗或津伤后欲饮水，须少少与饮，不可过饮；若兼脉浮小便不利之渴，则为消渴，当五苓散而非单纯灌水。



橘枳姜汤

组成

橘皮一斤 枳实三两 生姜半斤

比例

枳实3 陈皮16 生姜8

病理

气实

病理症状

气实

胸满痞塞、短气痞闷；暖气频作，暖后觉舒

易混淆方

茯苓饮

桂枝生姜枳实汤

半夏厚朴汤

旋覆代赭汤

方剂	核心区别
橘枳姜汤	胸痹气滞，胸中气塞、短气、心下痞满，橘皮枳实生姜行气降逆。
茯苓饮	胃虚停饮，吐水、食后胀满、心胸有气，水饮更重。
桂枝生姜枳实汤	气冲心痛，心中痞、诸逆、心悬痛。
半夏厚朴汤	痰气咽阻，咽中如有炙脔。
旋覆代赭汤	胃虚噎气，噎气不除、心下痞硬。

辨证要点

胸中气塞为主，胸满、心下憋、堵闷明显

短气可见，但短气不是主症；短气急迫为主者偏茯苓杏仁甘草汤，

暖气频作，暖后觉舒

满闷而不以疼痛为主；胸痛明显者不可只按本方处理

相关原文

《金匮要略·胸痹心痛短气病》：胸痹，胸中气塞，短气，茯苓杏仁甘草汤主之，橘枳姜汤亦主之。

《肘后》《千金》：治胸痹，幅幅如满，噎塞习习如痒，喉中涩燥，唾沫。

医案

《金匮名医验案精选》咳嗽案：何某，男，34岁。咳嗽已五年，久治未愈，西医诊为支气管炎，曾用棕色合剂、青霉素等；中医按久嗽用半夏露、麦金杏仁糖浆等，皆不效。细询其咳虽久而不剧，痰亦不多，主要表现为入夜胸中似有气上冲至咽喉，呼吸作声、短气，胃脘、胸胁及背部隐隐作痛，畏寒、纳减，脉迟而细，苔薄白。证似《金匮》胸痹胸中气塞短气。予橘枳生姜汤加味：橘皮12g，麸炒枳实9g，生姜15g，姜半夏12g，茯苓12g。三剂后诸症消退，胁背痛亦止；后以原方出入，五年宿疾基本痊愈。

十二字病理分析：

气实：气上冲咽喉、短气、呼吸作声，

里虚寒/水证：久咳、畏寒、纳减、脉迟细，为胃气不足、寒饮内停之象，所以验案中加半夏、茯苓以化饮降逆。

此案虽以久咳就诊，但方证关键不是咳嗽本身，而是胸中气塞、短气、气上冲咽喉。